

Онкология и радиология Казахстана

№2-3 (24-25) 2012

Қазақстан онкология және радиология журналы

Главный редактор
К.Ш. Нургазиев, д.м.н.

Редакционная коллегия

Абисатов Х.А., Адильбаев Г.Б., Есентаева С.Е. (зам.гл.редактора), Жолдыбай Ж.Ж.,
Ижанов Е.Б., Кайрбаев М.Р. (административный редактор), Ким В.Б., Нурғалиев Н.С.
Жилкайдарова А.Ж., Талаева Ш.Ж., Чичуа Н.А., Иманғалиева Н.Т.

Редакционный совет

Давыдов М.И. (Россия)	Ш. Фуджи (Япония)
Мусулманбеков К.Ж. Казахстан	В. Кешич (Сербия)
Шарман А.Т. (Казахстан)	М.А. Мур (США)
Алчинбаев М.К. (Казахстан)	Р. Якез (Австрия)
М. Россели (Италия)	К. Нарайян (Австралия)

Ответственный секретарь

Кабдрахманов К.Б.

Редакторы переводов

Галушкин М.А., Утельбаева А.Е., Шалбаева Р.Ш.

Адрес редакции

г. Алматы, 050022, пр. Абая, 91

Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК

Тел. (327) 292 10 63

«Онкология и радиология Казахстана», №1 (23), 2012 г.

Собственник - РГКП «Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК»

Свидетельство о регистрации - №10248-ж от 14.07.2009 г.

Тип. «Идан», ул. Коммунальная, 39

Тираж 500 экз.

Журнал выпускается 1 раз в 3 мес.

Содержание

Организация здравоохранения

Д.Х.Савхатов. Клинико-эпидемиологические аспекты рака кожи в Казахстане (3)

И.Тажединов. Современное состояние и перспективы развития ядерной медицины в Казахстане (6)

А.И.Тажединов. Патологии пищевода, желудка и 12 перстной кишки, выявленные при эзофаго-строудоденоскопии (9)

В помощь практическому врачу

Ж.Ж.Жолдыбай. Лучевая диагностика опухолей пищевода (лекция) (12)

Вопросы диагностики

А.И.Шибанова. Современная технология и эффективность диагностики опухолей методом клинической цитологии (14)

Г.А.Тлеугабилова. Ранняя диагностика опухолей кожи (16)

С.Б.Бердаuletов, Ш.У.Аязбаев, К.К.Саргожаев. К оценке диагностических возможностей компьютерной и магнитно-резонансной томографии в обнаружении продолженного роста анапластических глиом головного мозга (19)

Хирургическое лечение

Ж.А.Арзыкулов, Е.Б.Ижанов, Е.Ш.Абзалбек. Отдаленные результаты мультимодальной терапии рака пищевода (21)

Б.Т.Мухамдиев. Анестезиологическое обеспечение эндотрахеобронхиальных операций при опухолевом поражении

центральных бронхов и трахеи (23)

А.К.Адильшин, Т.М.Пахомова. Гигантская киста яичника (26)

Г.А.Серикбаев, Д.А.Тулеева, А.К.Косаев, Ж.О.Мауленов. Непосредственные результаты хирургического лечения сарком мягких тканей (28)

Лекарственная терапия

Г.А.Тлеугабилова, Б.Ш.Кожаметов, Р.Р.Абдулаханова, Ж.Ж.Калиева. Лечение дисгормональных нарушений молочной железы (30)

Лучевая терапия

Е.И.Ишкинин, В.Б.Ким, М.А.Ибраимова. Применение лучевой терапии и бисфосфонатов для паллиативной помощи пациентам с метастатическим поражением костей скелета при раке почки (33)

Р.С.Бегимбетова. Лучевая терапия рака шейки матки (39)

Юбиляр

Г.Д.Сейтказина. 90 лет Балмуханову С.Б. (41)

Памяти коллег

К.Рахимов. О научно-педагогической, практической и общественной деятельности профессора О.К. Кабиева (К 80-летию со дня рождения) (43)

Газиз Сергазыулы Кананиянов (45)

УДК: 616-5-006-036/22(574)

Д.Х.Савхатов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Клинико-эпидемиологические аспекты рака кожи в Казахстане

Аннотация.

Рак кожи в структуре злокачественных опухолей в Казахстане занимает второе место после рака легких. Частота заболеваемости раком кожи у женщин в 1,5 раза выше, чем у мужчин. Тренды заболеваемости раком кожи в различных областях были неодинаковыми. Выявлены регионы с низкими и очень высокими показателями заболеваемости раком кожи. Обнаружены взаимосвязи заболеваемости раком кожи с удельным весом казахского населения.

Формирование кожно-фасциальных и кожномышечных трансплантатов с учетом полноценного кровоснабжения за счет сосудистых ножек позволяет успешно ликвидировать сложные по расположению и рельефу дефекты. Результаты подтвердили высокую эффективность разработанной методики криогенного метода при поверхностных формах новообразований.

Ключевые слова: рак кожи, заболеваемость.

Злокачественные новообразования кожи многие годы сохраняют третье место в эпидемиологической структуре злокачественных опухолей на территории СНГ. Наивысший показатель заболеваемости раком кожи (до 50% всех опухолей) отмечен в Австралии, где он в 10 раз выше, чем в Англии. Установлено, что более 33% всех злокачественных опухолей встречаются среди белого населения, проживающего в Австралии, Африке, Южной Америке, южных штатах США. В то же время в районах, жители которых имеют пигментированный кожный покров, рак кожи встречается относительно редко.

Условиями, определяющими это распространение, являются степень пигментации кожи, активность ультрафиолетовой радиации, длительность пребывания населения на открытом воздухе и воздействие на кожу химических продуктов, содержащих полициклические ароматические углеводороды и радиоактивного облучения.

Эпидемиологические исследования, проведенные в 50-70-х годах прошлого столетия на территории Казахстана и Киргизии, выявили определенные закономерности распространения рака кожи в зависимости от места проживания и этнического состава населения [1, 2]. Так, заболеваемость раком кожи среди русских, украинцев и белорусов, имеющих слабую степень пигментации кожи, составила 41,5‰, у татар со средней степенью пигментации - 15,5‰, а у казахов - 6,8‰, киргизов - 5,4‰, корейцев - 4,6‰ и уйгур - 4,3‰. То есть, у со сильной пигментацией этот показатель оказались самыми низкими. Однако в последние 20-30 лет целенаправленные эпидемиологические изучения рака кожи на территории Казахстана не проводились.

Проводят различные методы лечения рака кожи, вклю-

чающих проведение хирургических операций, лучевую и химиотерапию. Внедрение кожно-фасциальных и кожно-мышечных лоскутов при пластике послеоперационных дефектов позволяет ликвидировать дефект, увеличивает количество сохраненных операций и качество жизни пациента, что является актуальным в наши дни.

Криогенный метод позволяет максимально сохранять местные ткани, достигать хороших косметических отдаленных результатов при лечении рака кожи головы и лица и применяется в настоящее время как в самостоятельном варианте (криодеструкция опухоли), так и в сочетании с другими методами лечения (лучевой терапией, химиотерапией, иммунотерапией, фото-динамической терапией). Учитывая это обстоятельство, мы попытались восполнить этот пробел по данной проблеме.

Материалы и методы исследования.

Материалом исследования послужили данные онкологических учреждений республики, касающиеся 19552 больных раком кожи, зарегистрированных за 2000-2006 годы, а также 153 больных раком кожи, получивших лечение в условиях отделения опухолей костей и мягких тканей.

Хирургическое лечение проведено 68 больным, 85 больных получили криотерапию.

Методика криодеструкции предполагает 3-4 цикла криовоздействия - глубокого замораживания опухоли до ультранизких температур с помощью специальных медицинских криоаппаратов. В качестве хладагента, как правило, используется жидкий азот с температурой -196°C.

Статистическая обработка материала произведена по общепринятой методике медико-биологической статистики, применяемой в медицине [3].

Картограмма составлена по способу и методике, предложенной С.И. Игисинным [4].

Результаты

Среднегодовой показатель заболеваемости раком кожи всего населения Казахстана за 2000-2006 гг. составил 18,6‰, в структуре злокачественных опухолей он занимает второе место после рака легких. Уровень заболеваемости раком кожи в разных областях Казахстана неодинаков. Высокие показатели заболеваемости раком кожи установлены в Восточно-Казахстанской (41,5‰), Карагандинской (28,9‰), Павлодарской (22,3‰), Костанайской (19,9‰) областях и в г. Алматы (32,3‰), относительно средние показатели - в Северо-Казахстанской (17,7‰), Акмолинской (16,0‰), Западно-Казахстанской (13,5‰), Алматинской (13,2‰), Актыубинской (12,7‰) областях и в г. Астана (16,1‰), а низкие - в Жамбылской (10,8‰), Южно-

Казахстанской (8,8‰), Кызылординской (5,8‰), Мангыстауской (5,2‰) областях (Рисунок 1).

В динамике показатели заболеваемости всего населения раком кожи имели различные тенденции роста или снижения (Рис. 2). Тренды заболеваемости раком кожи в республике имеют тенденции к росту ($T=0,73\%$). Самые высокие темпы прироста показателей заболеваемости раком кожи выявлены в Восточно-Казахстанской ($T=1,7\%$), Карагандинской ($T=1,24\%$), Костанайской ($T=0,77\%$), Павлодарской ($T=0,73\%$), Актыбинской ($T=0,73\%$), Северо-Казахстанской ($T=0,69\%$), а низкие - в Акмолинской ($T=0,25\%$) и Южно-Казахстанской ($T=0,1\%$) областях. В то же время в г. Алматы ($T=-1,98\%$), Астана ($T=-1,13\%$) и в Кызылординской ($T=-0,44\%$), Мангыстауской ($T=-0,23\%$), Алматинской ($T=-0,20\%$), Атырауской ($T=-0,14\%$), Жамбылской ($T=-0,14\%$) и Западно-Казахстанской ($T=-0,05\%$) областях тренды заболеваемости имели тенденцию к снижению.

Высокие темпы снижения заболеваемости имели место в г. Алматы и Астане.

Нами проведен сравнительный анализ заболеваемости раком кожи у мужчин и женщин в тех областях Казахстана, где среднегодовые показатели заболеваемости раком кожи были выше по сравнению с республиканскими данными (Рисунок 2). При этом установлено, что частота заболеваемости раком кожи у женщин в 1,5 раза выше, чем у мужчин. Самые высокие показатели заболеваемости раком кожи у женщин (49,6‰) и мужчин (33,1‰) выявлены в Восточно-Казахстанской области. Аналогичные данные получены в Карагандинской области (32,0 и 22,7‰, соответственно) и в г. Алматы (31,4 и 20,0‰, соответственно).

Жамбылской (10,8) и Актыбинской (12,7) областях. Средний показатель (шкала 12,7-22,3‰) - в Алматинской (13,2), Западно-Казахстанской (13,5), Акмолинской (16), Северо-Казахстанской (17,7), Костанайской (19,9) областях и в г. Астана (16,1), а высокий (шкала в 22,3-32,1‰) - в Павлодарской (22,3) и Карагандинской (28,9) областях. Самый высокий уровень заболеваемости (шкала 32,1-41,8‰) раком кожи выявлен в г. Алматы (32,3) и в Восточно-Казахстанской (41,5) области. Эти различия, в основном, связаны с удельным

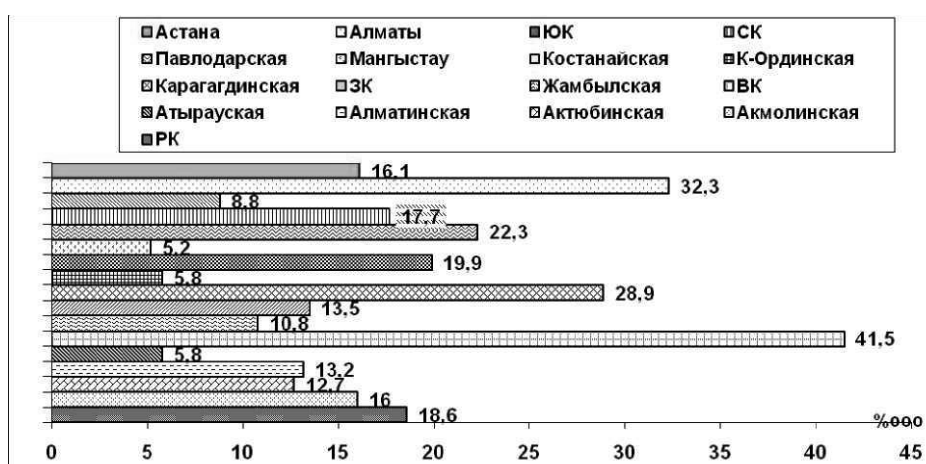


Рисунок 1- Среднегодовые показатели заболеваемости всего населения раком кожи в Казахстане за 2000-2006 гг.



Рисунок 2 - Среднегодовые показатели заболеваемости населения по половой принадлежности в некоторых регионах Казахстана с высокой частотой заболеваемости раком кожи за 2000-2006 гг.

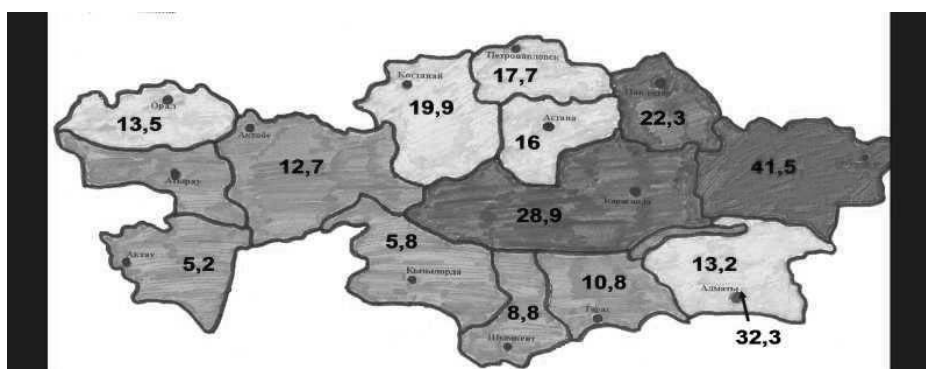


Рисунок 3- Картограмма распространения рака кожи в Казахстане

весом казахского населения: там, где его доля выше 60% в структуре населения, частота возникновения рака кожи самая низкая. К таким областям относятся Мангыстауская, Атырауская, Кызылординская, Жамбылская и Актыбинская. В то же время в областях, где доля казахского населения составила до 50% в структуре населения, показатели заболеваемости раком кожи относительно высокие, а в областях, где эти данные ниже 30%, уровень заболеваемости очень высокий (Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Карагандинская области и г. Алматы).

В отделении опухолей костей и мягких тканей Казахского НИИОиР с 2002 по 2007 гг. кожно-фасциальная и кожно-мышечная пластика после радикального иссечения злокачественных опухолей применена у 68 больных. У 14 больных дефект кожи наружного носа был закрыт кожно-фасциальным лоскутом со лба, при дефектах кожи лица пластика выполнена кожно-фасциальным лоскутом на сосудистой ножке из височной области у 12 больных.

При злокачественных опухолях кожи нижней губы у 28 больного послеоперационный дефект был закрыт кожно-мышечным лоскутом с включением m. depressor angulioris. Для замещения дефектов в других анатомических областях применены следующие виды пластики: торакодорзальным лоскутом - у 8, кожно-мышечным лоскутом на лучевой артерии - у 2, кожно-мышечным лоскутом с включением трапецевидной мышцы - у 4 больных.

С 2000 по 2007 гг. для лечения базальноклеточного рака кожи 85 больным была проведена криотерапия, из них с I стадией пролечено 30 пациентов, со II стадией - 35 и III стадией - 20. За период наблюдения у 2-х больных с III стадией отмечался рецидив через 3-6 месяцев после лечения, который излечился повторной криотерапией.

Таким образом, рак кожи в структуре злокачественных опухолей в Казахстане занимает второе место после рака легких. Частота заболеваемости раком кожи у женщин в 1,5 раза выше, чем у мужчин. Тренды заболеваемости раком кожи в различных областях были неодинаковыми. Выявлены регионы с низкими, и очень высокими показателями заболеваемости раком кожи. Выявлены взаимосвязи частоты заболеваемости раком кожи с удельным весом казахского населения. Формирование кожно-фасциальных и кожно-мышечных трансплантатов с учетом полноценного кровоснабжения за счет сосудистых ножек позволяет успешно ликвидировать сложные по расположению и рельефу дефекты. Результаты подтвердили высокую эффективность разработанной методики криогенного метода при поверхностных формах новообразований.

Список литературы

1. Смирнов В.А., Фунштейн Л.В. Пигментация и рак кожи в Казахстане // Эпидемиология злокачественных опухолей.- Алма-Ата, 1970. - С. 151-159.
2. Ильязов А.И. Заболеваемость раком кожи в Киргизии // Советское здравоохран. Киргизии.- 1963. - № 4-5. - С. 70-75.
3. Мерков А.М., Поляков Л.Е. Санитарная статистика. - Л.: Медицина, 1974. - 384 с.
4. Игисинев С.И. Способ составления и применения картограмм в онкологической практике // Здравоохран. Казахстана. - 1974. - № 2. - С. 69-71.
5. Пустынский И.Н., Любаев В.Л. Современные возможности криогенного и крио-лучевого лечения больных местнораспространенным раком кожи головы // Вестник Моск. Онкол. Общества. - 2005. - №5 - С. 3-4.

Тұжырым

Д.Х.Савхатов

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Қазақстандағы тері обырының клиника-эпидемиологиялық көрінісі

ТМО территориясында тері қатерлі ісіктерінің үшінші орында орналасқан, Қазақстан Республикасында тері қатерлі ісігінің жалпы қатерлі ісіктері ішінде екінші орында тұрақтылығы тіркелуде. Ер азаматтарға қарағанда әйел кісілерде тері қатерлі ісігі 1,5 есе көп. Тері қатерлі ісігінің мөлшері Қазақстан аймақтарында әр-түрлі сандық көрсеткіште. Ісік басқа ұлт өкілдерін қарағанда қазақ ұлты өкілдерінде әлсіз кездеседі.

Кеңейтілген отадан кейін орын алатын ашық жараны жабуға тері-фасциалды және тері-етті трансплантаттардың ыңғайлы екендігі анықталды. Терінің жоғарғы қабатында орын алған қатерлі ісіктерді емдеуді мұздатылған сұйық азотының тиімді екендігі дәлелденді.

Түйінді сөздер: тері обыры, аурушандық, Қазақстан.

SUMMARY

D.H.Savhatov.

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Clinical and epidemiological aspects of skin cancer in Kazakhstan

Malignant neoplasms of the skin for many years held the third place in the epidemiological structure of malignant tumors in the CIS. Skin cancer malignancy in Kazakhstan ranks second, after lung cancer. The incidence of skin cancer in women is 1.5 times higher than in men. Trends in the incidence of skin cancer in various areas has been uneven. Identified regions with low and very high incidence of skin cancer. The relationships of frequency of skin cancer with a specific weight of the Kazakh population. Formation of skin-fascial and skin-muscle grafts given a full blood supply due to vascular legs can successfully eliminate complicated by the location and topography of defects. The results confirmed the high efficiency of the developed technique of cryogenic method for superficial forms of neoplasms.

Keywords: skincancer, incidence, Kazakhstan.

УДК:615.849(574)

И.Тажединов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Современное состояние и перспективы развития ядерной медицины в Казахстане

Аннотация. Пережив сложный переходный период, ядерная медицина Республики Казахстан обретает тенденцию к восстановлению. Первый ПЭТ-центр открылся в 2010 году в Республиканском диагностическом центре г. Астаны. В рамках реализации «Программы развития онкологической помощи в РК на 2012-2016 гг.» утвержденной правительством, планируется проект по открытию Центров ядерной медицины в Казахском НИИ онкологии и радиологии, Региональном онкологическом диспансере г. Семей, Национальном научном онкологическом центре, открытие которого планируется в г. Астана.

Ключевые слова: ядерная медицина, радионуклидная диагностика, радиоиммунный анализ, радионуклидная терапия.

Современная ядерная медицина состоит из разделов: радионуклидная диагностика, радиоиммунные анализы и радионуклидная терапия. В нашей республике применяются радионуклидные *in vivo* и *in vitro* методы исследования. Радионуклидная терапия до настоящего времени в Казахстане не организована.

Радионуклидная диагностика основана на принципе регистрации и измерения γ -излучений, исходящих из введенных в организм человека (*in vivo*) радиофармацевтических препаратов (РФП) для изучения функции и анатомо-топографического состояния органов и систем.

Радионуклидные *in vivo* и *in vitro* методы (РИА) применяются для определения различных жизненно важных веществ, в биологических пробах, чаще всего сыворотке крови.

Радионуклидная терапия основана на применении метаболически активных радионуклидов и меченых соединений в организме, избирательно накапливающихся в очагах злокачественной опухоли и метастазах.

Качество и эффективность преподавания любого предмета зависят от широты внедрения метода в клиническую практику. В 1987 году Казахстан среди союзных республик с 25 лабораториями радионуклидной диагностики занимал 5-е место [1]. На одну лабораторию приходилось 661520 жителей населения, что соответствовало 10-му месту. В республике функционировало 10 гамма-камер, с нагрузкой на каждую 582,5 обследованных, что также соответствовало 10-ому месту. Число обследованных на 100000 населения в Республике составляло 4,3, тогда как в СССР - 7,1; в США - 32; в Японии - 15; в странах западной Европы - 8-15.

Широта внедрения короткоживущего радионуклида $^{99\text{Tc}}$ с периодом полураспада $T_{1/2}=6,02$ часа (качественный показатель) в СССР составляла 15% (1985), в Японии - 64% (1983), в Англии - 75% (1982). Другой короткоживущий радионуклид $^{123\text{I}}$, циклотронный, с $T_{1/2}=13,3$ часа

в диагностике заболевания щитовидной железы в СССР еще не был использован, а его применение в Японии составляло 5,2%, в Англии 2,2%. Тогда как использование менее короткоживущего радионуклида $^{131\text{I}}$ $T_{1/2}=8,05$ от общего количества обследованных радионуклидными методами составляло 70%, 13% и 55,1%, соответственно.

По данным МАГАТЭ в 1982 году для производства радионуклидов в медицинских целях в мире использовалось 83 циклотрона, больше половины из них в экономически развитых странах: в США - 31, в ФРГ - 8, в Японии - 7. В СССР только два циклотрона эпизодически работали для медицины. К 1990 году позитронно-эмиссионные томографы (ПЭТ) использовались в более чем 60 медицинских центрах и клиниках мира: 21 - в США, 8 - в Японии, 5 - в ФРГ.

Служба радионуклидной диагностики Казахстана, как у всех союзных республик, была оснащена по линии СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) оборудованием комбината ГАММА (Венгрия), в том числе, планарными гамма-камерами «SEGAMS» (Supersegams, Mikrosegams, Segams80). Израсходовав свои эксплуатационные ресурсы, многие гамма-камеры в республике не функционировали. В 1999 году, учитывая создавшуюся сложную ситуацию, Комитет здравоохранения организовал «Национальный семинар по проблемам радиационной защиты и радионуклидной диагностики». Принятая на семинаре «Концепция совершенствования службы радионуклидной диагностики и обеспечения радиационной безопасности рентгено-радиологических медицинских исследований в Республике Казахстан» была утверждена приказом Комитета здравоохранения №194 от 13.04.1999г.

Одним из вопросов семинара была программа РИР, разработанная в Словении для подключения к гамма-камере персонального компьютера, заменяющего ЭВМ. Разработанная интерфейсная карта к персональному компьютеру выпускалась в Индии, которая по линии МАГАТЭ поставлялась для установки ее и подключения к гамма-камере. Благодаря этой программе лаборатория сохранилась. На этой установке проведены испытания первых отечественных радионуклидов.

Другой основной причиной отставания развития Ядерной медицины в республике явилось отсутствие производства собственных радиофармацевтических препаратов (РФП). На этом семинаре, где участвовали сотрудники Института ядерной физики (ИЯФ), было принято решение о выпуске отечественных РФП.

С тех пор, из-за финансовых затруднений переходного периода, в республике стали закрываться лаборатории одна за другой. К тому же, стало экономически невыгодно закупать РФП у основного поставщика для Средней Азии и Казахстана - Объединения «Радиофармапрепарат» (Ташкент, Узбекистан). Вот уже более 15 лет студенты многих медицинских ВУЗов знакомы с радионуклидной

диагностикой только по учебникам, в лучшем случае, по радиодиагностическим установкам нефункционирующих лабораторий. В результате, у выпускников сложилось мнение о радионуклидной диагностике как о методе второстепенной важности. Клиницисты, ранее использовавшие результаты этого метода, стали забывать о нем, отдавая предпочтение УЗИ, КТ, МРТ. Тем самым, в клинической медицине республики радионуклидные исследования не нашли прочного места в комплексе диагностических методов. В то же время, методы визуализации, применяемые в интроскопии, принципиально отличаются друг от друга. Радионуклидная диагностика от других методов визуализации выгодно отличается функциональностью и биогенностью.

В настоящее время в ИЯФ НЯЦ РК налажен выпуск самых необходимых радионуклидов и меченых соединений, как ^{131}I , $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -генератор, ^{67}Ga -цитрат, которые успешно прошли экспериментально-клинические испытания в лаборатории радионуклидной диагностики Казахского НИИ онкологии и радиологии (Каз-НИИОиР), единственной сохранившейся из 25 прежних [2-5]. В 2008 году экспериментальные и 1-2 фазы клинического испытания прошли ^{131}I -гипуран и первый реагент к генератору - ДТГА, предназначенные для диагностики заболеваний почек и мочевых путей [6]. 3-й этап клинических испытаний завершится в 2012 году. В настоящее время налажен серийный выпуск $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -генератора [7].

Выпуск генератора был значительным достижением и станет новым толчком в развитии ядерной медицины. Теперь лабораторию радионуклидной диагностики можно организовать в любом городе республики. $^{99\text{m}}\text{Tc}$ является универсальным метчиком в получении РФП. Для полноценного применения генератора необходимо разработать другие специфичные к нему реагенты, предназначенные для оценки структурных и функциональных изменений органов и систем. Для увеличения количества потребителей генератора и расширения применения в клинической медицине столь необходимого метода, как радионуклидная диагностика, следует открыть новые лаборатории радионуклидной диагностики.

Пережив сложный переходный период, ядерная медицина Казахстана обретает тенденцию к восстановлению. За последние годы, впервые в республике, в 2007 году КазНИИОиР приобрел современную гамма-камеру PHILIPSFORTE-ОФЭКТ. Такого же класса гамма-камера фирмы SIEMENS работает в новой лаборатории радионуклидной диагностики НИИ кардиологии и внутренних болезней.

В рамках реализации Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012 - 2016 годы, утвержденной Правительством, планируется проект по открытию Центров ядерной медицины (ЦЯМ) в КазНИИОиР и Региональном онкологическом диспансере (РОД) г. Семей, а также в Национальном научном онкологическом центре, открытие которого планируется в г. Астана.

Первый в республике ПЭТ-центр открылся в 2010 году в Республиканском диагностическом центре (РДЦ) г. Астаны. Этот центр оснащен ПЭТ/КТ- и ОФЭКТ-сканерами.

У циклотрона в медицине большие возможности и перспективы [8-11]. Многие радионуклиды диагностического и лечебного применения получают на циклотронах. Среди них особо отличаются короткоживущие радионуклиды - позитрон-излучатели ($E_{\gamma}=511$ кэВ) жизненно важных элементов ^{11}C , ^{13}N , ^{15}O , с $T_{1/2}$ 20,5, 10,2, 2,05 минут, соответственно, и ^{18}F с $T_{1/2}$ 1,83 часа. Особо широкое применение в онкологии находит ^{18}F -ФДГ.

Современный ПЭТ-центр - сложный дорогостоящий комплекс, состоящий из медицинского циклотрона, радиохимической лаборатории и лаборатории радионуклидной диагностики. Последнее подразделение является аналогом современной одноименной лаборатории, где наряду с гамма-камерами ОФЭКТ- или ОФЭКТ/КТ-сканер располагается и ПЭТ/КТ-сканер.

В республике необходимо организовать центр радионуклидной терапии. Радионуклидная терапия основана на клеточном механизме злокачественного роста, обеспечивающая повреждения в метаболической активной фазе [12-14]. Впервые в республике в КазНИИОиР доклинические испытания проходят ^{131}I для радиойодотерапии зрелых форм рака щитовидной железы и токсического зоба, а также ^{153}Sm -ЭДТМФ для радионуклидной терапии метастатических очагов в костях скелета. В последующем можно внедрять более сложные методы радионуклидной терапии.

Неотъемлемая часть ядерной медицины - высокоточный метод РИА. Радиоиммунологическая служба может входить в состав лаборатории радионуклидной диагностики, как, например, в КазНИИОиР, или в составе лаборатории эндокринологии в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии, в Региональном диагностическом центре г. Алматы.

Для освоения сложной технологии ПЭТ, прежде всего, необходимо наладить базовую в ядерной медицине службу радионуклидной диагностики. В первую очередь, требуется открыть лаборатории в городах, где имеются медицинские ВУЗы. Преподавание предмета должно быть обеспечено врачом по радионуклидной диагностике. Научные разработки и диссертационные работы, выполненные с применением радионуклидного исследования, всегда подчеркивают их высокий методический уровень и новизну. Поэтому необходимо открытие лабораторий в медицинских научно-исследовательских институтах. В связи с этим, в Институте кардиологии и внутренних болезней лаборатория радионуклидной диагностики находится на стадии открытия. Если учесть, что более 50% радиодиагностических исследований проводятся больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это успешный путь в развитии ядерной медицины в республике Казахстан. Учитывая, что нуждающихся в радионуклидной диагностике в республике много, необходимо открыть специализированные лаборатории во всех областных центрах и крупных городах, а также в больничных комплексах и больших клиниках.

Высокий уровень развития медицины, приоритетность современных технологий и интеллектуального потенциала, социальная ориентированность развития нашего государства позволяют развивать ядерную медицину в республике.

Список литературы

- 1 Касаткин Ю.Н., Лясс Ф.М., Габуня Р.И. и др. Основные проблемы радионуклидной диагностики в СССР // *Мед. радиол.* - 1990. - Т.35, №10. - С.29-37.
- 2 Мясников А.В., Тамаева К., Мустафина М.М., Тулеушева М.А. Опыт получения йода-131 в ИЯФ НЯЦ РК // *Тр. 5-й Междунар. конф. «Ядерная и радиационная физика»*. - Алматы, 2005.
- 3 Чакров П.В., Банных В.И., Тамаева К., Чакрова Е.Т. Способ получения радиофармацевтического препарата с $^{99\text{m}}\text{Tc}$ // *Патент №36753* выдан 2001. 29.11.
- 4 Чумиков Г.Н., Бердинова Н.М., Муратова В.М. и др. Способ получения радиофармпрепарата Галлий-67 (^{67}Ga) // *Патент №12131* выдан 2001.04.07.
- 5 Чакров П.В., Чакрова Е.Т., Банных В.И. и др. Опыт

производства гелий-генераторов ^{99m}Tc в Казахстане //Труды 7-й междунар. конф. «Ядерная и радиационная физика». - Алматы, 2009. -С.248.

6 Тажединов И.Т., Нургаалиев Н.С., Косанов М.С. и др. Клиническое исследование радиофармпрепаратов «Наприя-о-йодгиппурат, ^{131}I -раствор для инъекций» (лекарственная форма: раствор для инъекций) и «ДТПА- ^{99m}Tc - раствор для инъекций, внутривенно», предназначенные для динамических сцинтиграфии почек, производства ИЯФ НЯЦ РК // Мат. 8-ой междунар. конф. «Ядерная и радиационная физика», посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан.- Алматы, 2011.- С. 495-499.

7 Тажединов И.Т., Хан О.Г., Чакрова Е.Т., Банных В.И.. Клинические исследования препарата «Раствор пертехнетата ^{99m}Tc » из гелий-генератора, производства ИЯФ НЯЦ РК // Мат. 8-й Междунар. конф. «Ядерная и радиационная физика», посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан.- Алматы, 2011.- С. 491-495.

8 Тажединов И.Т., Джалмукашев У.К. Циклотронные радионуклиды в медицине (диагностике) Казахстана //Тр. 2-й Междунар. конф. «Ядерная и радиационная физика». Ядерная и прикладная физика.- Алматы, 1999. - Т. I.- С.65-66.

9 Гранов А.М., Тютин Л.А., Виноградов В.М. и др. Опыт организации лучевой терапии, лучевой диагностики, циклотронного комплекса, ПЭТ-центра и радиационной стерилизации в ЦНИРРИ / В кн.: Высокотехнологичные онкордиологические центры. Научные и методические аспекты. Сб. мат. научно-практических конф.- М., 2007.- Выпуск 1.- С. 109-110.

10 Труфанов Г.Е., Декан В.С., Рудь С.Д., Бойков И.В. Основы и клиническое применение радионуклидной диагностики (ПЭТ/КТ и ОФЭКТ) //В кн.: Сборник по актуальным вопросам лучевой диагностики и лучевой терапии.- С-Пб.:ЭЛБИ, 2004. -С.67-116.

11 Хмелев А.В., Ширяев С.В., Костылев В.А. Позитронная эмиссионная томография.- М.: АМФ - Пресс, 2004.- 67с.

12 Терапия открытыми радиоактивными веществами //В кн.: Ядерная медицина. -Алматы: Sansat, 2008.- С.256-282.

13 Наркевич Б.Я., Костылев В.А., Глухов С.Б. и др. Медико-физические основы радионуклидной терапии / Учебное пособие.- М., 2006. -59 с.

14 Наркевич Б.Я., Ширяев С.В. Радионуклидная терапия: клинические и физико-технические аспекты // Сб.мат. научно-практических конф. «Научные и организационные проблемы создания и эффективного использования высокотехнологичных онкордиологических центров».-М., 2007.-Вып. 1.- С. 39-47.

15 Наркевич Б.Я., Костылев В.А., Иванов С.И. и др. Основы обеспечения радиационной безопасности в медицине //Учебное пособие.- М., 2006.-71с.

Тұжырым

И.Т.Тажединов

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Қазақстандағы ядролық медицинаның келешекте дамуының қазіргі заманға сәйкес жағдайы

Ядролық медицина Республикамызда етпелі кезеңнің қиындықтарынан кейін дамудың қалыптасу жолына түскен. Бірінші ПЭТ-орталығы Астанада Республикалық диагностикалық орталықта 2010 жылы ашылды. Окімет бекіткен 2012-2016 жылдар аралығында Қазақстан Республикасында Онкологиялық көмекті дамыту бағдарламасын жүзеге асыру аясында, Алматыдағы Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу институтында, Семейдегі Аймақтық онкологиялық диспансерде және де Астанада ашылғалы отырған Ұлттық онкологиялық ғылыми орталықта Ядролық медицина орталықтарын ашу жоспарланып отыр.

Түйінді сөздер: ядролық медицина, радионуклиттік диагностика, радиоиммундық анализ, радионуклиттік терапия.

Summary

I.T.Tazhedinov

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Current status and prospects of development of nuclear medicine in Kazakhstan

Having endured the difficult transitive period, Nuclear medicine of Republic finds a tendency to restoration. The first PET-Center has opened in 2010 in the Republican diagnostic center in Astana. Within the limits of realization of the Program of development of the oncological help in Republic of Kazakhstan for 2012-2016 confirmed the government plans the project on opening of the Centers of Nuclear medicine in Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology, the Regional oncological clinic in Semey, the National scientific oncological center which will planned to open in Astana.

Keywords: nuclear medicine, radionuclide diagnostics, radioimmunoassay, radionuclide therapy.

УДК:616.329+/.33-072.1

А.И.Тажеудинов

ГГКП «Региональный диагностический центр», г. Алматы, РК

Патологии пищевода, желудка и 12-перстной кишки, выявленные при эзофагогастродуоденоскопии

Аннотация. Анализ результатов исследований, проведенных за 2009-2011 гг. показал, что воспалительные процессы верхнего отдела ЖКТ встречаются значительно чаще, чем другие виды патологии. В рамках реализации Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы (№ 366от 29.03.2012) ожидается повышение количества эндоскопических исследований. В этом плане для верификации результатов эндоскопии необходимо увеличить количество исследований с взятием мазков и биопсионного материала.

Ключевые слова: эндоскопическая диагностика, пищевод, желудок, 12-перстная кишка.

Актуальность

В стадии реформирования здравоохранения Казахстана, в ежедневном потоке пациентов, структура нозологических форм среди выявляемых патологий может измениться. В специализированных диагностических центрах некоторые частые патологии могут иметь доминирующее значение в принятии диагностического решения, чем более редкие формы патологий при сходстве некоторых ведущих признаков. Появление новых, довольно мощных частных диагностических клиник, также может повлиять на структуру патологий, с которыми обращаются в профильные госучреждения. Среди эндоскопических исследований эзофагогастродуоденоскопия занимает первое место. Анализ частоты патологии и признаков заболеваний верхнего отдела желудочно-кишечного тракта всегда актуален.

Цель работы

- анализ структуры выполненных эндоскопических исследований желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) за 2009-2011 годы.

Материалы и методы

В таблице 1 приведена структура обращений пациентов по годам. Всего за 2009 год было проведено 3536 эзофагогастродуоденоскопий, в 2010 году - 3602 и в 2011 году - 2998 исследований. Среди обследованных пациентов впервые обратилось 9744 (96,13%) и повторно - 392 (3,87%) пациентов, из них взрослых - 9166 (90,43%) и детей - 970 (9,57%). В распределении по годам, заметного разброса этих показателей не видно, за исключением детей в 2010 году.

Таблица 1 - Эндоскопические исследования, проведенные за три года

№	Пациенты	2009	2010	2011	Показатели 2009-2011		
					Абс.	%	Всего
1	Первичные	3536	3602	2998	9744	96,13	10136
2	Повторные	178	89	125	392	3,87	100%
3	Взрослые	3340	2875	2951	9166	90,43	10136
4	Дети	196	727	47	970	9,57	100%

Таблица 2 - Виды эндоскопических исследований за 2009-11 гг.

Виды исследования	2009	2010	2011	Показатели за 3 года	
				Абс.	%-
Эзофагогастро-дуоденоскопия	3515	3573	2984	10072	94,37
Колоноскопия	18	29	14	61	0,57
Сигмоскопия	-	9	1	10	0,09
Всего	3533	3611	2999	10143	100

Повторных исследований значительно меньше, чем первичных. После установления диагноза, многие пациенты наблюдаются по месту жительства или проходят лечение в специализированных клиниках.

Только в отдельных случаях по личной инициативе пациенты в динамике проходят контрольное эндоскопическое обследование.

Общеизвестно, что эзофагогастродуоденоскопия проводится чаще у взрослых, чем у детей. Тем не менее, необходимо больше работать педиатрам и детским гастроэнтерологами для снижения запущенных патологий у детей.

Виды эндоскопических исследований приведены в таблице 2.

Эзофагогастродуоденоскопия является основным доступным методом в визуальной диагностике заболеваний верхнего этажа ЖКТ. Эзофагогастродуоденоскопия у 10072 пациентов составляет 94,37% всех эндоскопических исследований ЖКТ. Колоноскопия, сигмоскопия, взятие биопсионного материала для гистологии или мазка для цитологии, в сумме составляют всего 5,63% всех эндоскопических исследований ЖКТ.

Заболевания пищевода, выявленные при эзофагоскопии, приведены в таблице 3.

Наиболее часто встречается патология пищевода - это эзофагиты у 2852 (75,23%) и эрозивно-язвенные эзофагиты у 209 больных. Дивертикулы выявлены у 16 (0,42%), грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) - у 64

Таблица 3 - Структура заболеваний пищевода, выявленных при эзофагоскопии

№	Патологии	2009	2010	2011	Показатели за 3 года	
					Абс.	%
1	Эзофагиты	1083	897	872	2852	75,23
	в том числе эрозивные и эрозивно-язвенные эзофагиты	95	41	73	209	
2	Доброкачественные образования	11	3	2	16	0,42
3	Злокачественные опухоли	17	9	16	42	1,11
4	ГПОД	33	15	16	64	1,69
5	ВРВП	18	12	18	48	1,27
	Общее	1162	936	924	3022	100

Таблица 4 - Структура заболеваний желудка, выявленных при гастроскопии

Патологии	2009	2010	2011	Показатели за 3 года	
				Абс.	%
Гастриты из них:	3509	3573	2750	9832	94,67
а) атрофические	1514	1476	1199	4189	40,33
б) поверхностные	1612	1784	1262	4658	44,86
в) гипертрофические	11	13	4	28	0,27
г) эрозивные	372	300	285	957	9,21
Эрозия желудка	56	78	61	195	1,88
Язва желудка	35	9	38	82	0,79
Гастрит оперированного желудка	31	27	29	87	0,84
Пилоростеноз	2	-	-	2	0,02
Доброкачественные опухоли	45	20	29	92	0,89
Злокачественные опухоли	34	18	42	96	0,91
Общее	3712	3725	2949	10386	100

Таблица 5 - Структура и выявляемость заболеваний 12-перстной кишки

№	Патологии	2009	2010	2011	Показатели за 3 года	
					Абс.	%
	Дуодениты в т. ч.	2927	2610	1967	7504	72,47
	эрозивные	541	379	472	1242	
2	Язва луковицы	413	310	391	1114	10,76
3	Рубцовая деформация луковицы	621	469	646	1736	16,77
	Общее	3961	3389	3004	10354	100

(16,6%) - эрозивные. Язва луковицы 12-перстной киш- луковицы - 1736 (16,77%) больных. ки выявлены у 1114 (10,76%) и рубцовая деформация

(1,69%) и варикозное расширение вен пищевода (ВРВП) - у 48 (1,27%). У 42 (1,11%) больных гистологически подтверждена злокачественная опухоль пищевода. При такой низкой частоте в общем потоке неопухолевых патологий вероятность просмотра злокачественной опухоли пищевода слишком высока. Следовательно, при любой патологии, в первую очередь, необходимо исключить злокачественную опухоль пищевода. Взятие биопсионного

материала для гистологии, особенно мазка для цитологии, необходимо увеличить с 5 до 10% всех исследований пищевода. Такое расширение эндоскопического показателя к верификации диагноза является основой онкологической настороженности в эндоскопии.

Патологии желудка, установленные при гастроскопии, приведены в таблице 4, где гастриты выявлены у большинства - 9832 (94,67%) больных. В том числе определены атрофический гастрит у 4189 (40,33%), поверхностный - у 4658 (44,86%), гипертрофический - у 28 (0,27%) и эрозивный - у 957 (9,21%) пациентов.

Выявляемость доброкачественных и злокачественных новообразований остается на прежнем уровне и относительно одинакова. Цитоморфологическая верификация составила 91%.

Учитывая высокую заболеваемость раком желудка в республике, необходимо расширить показание на взятие мазка и/или биопсионного материала при фиброгастроскопии.

Среди патологии 12-перстной кишки дуодениты уставлены у 7504 (72,4 7%) больных, из них у 1242

Заключение

Анализ результатов исследований, проведенных за 2009-2011 гг. показал, что эзофагогастро-дуоденоскопия проводится значительно чаще, чем другие методы эндоскопии желудочно-кишечного тракта. Первичных исследований намного больше, чем повторных. Дети реже проходят эндоскопию, чем взрослые. Из-за «дефицита» детских гастроэнтерологов, педиатрам необходимо больше уделять внимание к жалобам детей. Воспалительные процессы верхнего отдела ЖКТ встречаются значительно чаще, чем другие виды патологии. В сравнении с исследованиями прошлых лет [1, 2, 3, 4] в структуре патологий явных отклонений не выявлено. В рамках реализации Программы развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012 - 2016 годы, утвержденной Правительством (№ 366от: 29.03.2012) ожидается повышение количества эндоскопических исследований. В этом плане для верификации результатов эндоскопий необходимо увеличить количество исследований с взятием мазков и биопсионного материала.

Список литературы

1. Тажединов А.И., Дуйсенбеков Ж.С., Салханов Б.А. Априорная вероятность патологии пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по результатам эзофагогастро-дуоденоскопии в условиях диагностического центра // В кн.: Организация и совершенствование диагностического процесса в новых экономических условиях. Сб. работ юбилейной научно-практической конференции ФРЛКЦ, посвященной 10-летию его деятельности.- Алматы, 1998.- С. 159-161.
2. Айсарова А.П., Жарихина Т.А., Кусакина Г.К. и др. Морфологические особенности рака желудка // Мат. международного конгресса «Современные достижения гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии»- Алматы, 2004.-С.80-81. А.И.Тажединов

Тұжырым

А.И.Тажединов

ГГКП «Аймақтық диагностика орталығы», Алматы қаласында РК

Өнештің ақауы, асқазан және он екі елі ішек, эзофагогастроуденоскопиядан анықталуы.

2009-2011 жылдары жүргізілген зерттеудің нәтижелерін талдау, патологияның басқа түрлеріне караганда асқазанчик жолдарының жотарты белтіндеп асқинулар процеедәуір жиі кездесесетидтн керсетл. КР 2012-2016 жылдары онкологияның кемек кесету жобасын кке асыру барысында /№366 29.03.2012 ж/эндоскопиялық зерттеулер саны кебеймек. Оның Ынде жакналармен биопсия материалдарын алып жасалынатын, нәтижес верификациялантан эндоскопиялық зерттеулер саны есуі керек.

Түйінді сөздер: эндоскопиялық зерттеу, өнеш, асқазан, он екі елі ішек

Summary

A.I.Tazhedinov

GGKP «Regional Diagnostic Center», Almaty, Kazakhstan
Pathology of the esophagus, stomach and duodenum 12, revealed during esophagogastroduodenoscopy.

Analysis of the results of studies conducted over 2009-2011 showed that inflammation of the upper GI occur much more frequently than other types of pathology. In the framework of the Program of development of cancer care in the Republic of Kazakhstan for 2012-2016 (№ 366 from 29.03.2012) is expected to increase the number of endoscopic examinations. In this respect, for the verification of endoscopies necessary to increase the amount of research with smears and biopsy material.

Keywords: endoscopic examinations, esophagus, stomach, duodenum 12.

УДК: 616.329-006-073

Ж.Ж.Жолдыбай

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Лучевая диагностика опухолей пищевода

Аннотация. Статья посвящена лучевой диагностике опухолей пищевода. Представлена анатомия, методика рентгенологического исследования с описанием характерных рентгенологических признаков доброкачественных и злокачественных опухолей пищевода.

Ключевые слова: рак пищевода, лучевая диагностика.

Пищевод - представляет собой фиброзно-мышечную цилиндрическую трубку шириной около 2 см, которая расположена между глоткой и желудком. Пищевод начинается на уровне нижнего края перстневидного хряща, что соответствует нижнему краю VI шейного позвонка, и заканчивается впадением в желудок, на уровне X-XII грудных позвонков. Длина пищевода в среднем равна 25 см (24,5-25 см у мужчин и 21-23,5 см у женщин). Шейный отдел пищевода сначала занимает срединное положение, затем он располагается несколько косо, слева от срединной линии. На уровне III-IV грудных позвонков пищевод отклоняется дугой аорты, а ниже - нисходящим ее отделом вправо. У VII грудного позвонка он лежит справа от средней линии. На уровне бифуркации трахеи пищевод смещается кзади проходящим впереди него левым главным бронхом. Выходя из-под левого бронха, пищевод отходит от позвоночника, направляется кпереди. Еще ниже он оттесняется кпереди и влево нисходящей аортой, постепенно вновь переходя на левую сторону. Пройдя через диафрагму, он располагается спереди и слева от срединной линии. Пищевод имеет 4 сужения: в месте перехода глотки в пищевод, на уровне дуги аорты, вдавление левого главного бронха, на уровне диафрагмы; 3 отдела: шейный (5-6 см), грудной (15-18 см) и абдоминальный (1-4 см). В грудном отделе пищевода выделяют верхнюю треть (около 5 см), соответствующую II-IV грудным позвонкам, среднюю (5-7 см) - на уровне V-VII грудных позвонков, и нижнюю треть (5-7 см), соответствующую уровню VII-X грудных позвонков. Так же различают 9 сегментов: 1) трахеальный - от входа в пищевод до верхнего края дуги аорты; 2) аортальный - соответствует диаметру дуги аорты; 3) бронхиальный - соответствует проекции левого главного бронха; 4) межаортобронхиальный - от нижнего края дуги аорты до верхнего края левого главного бронха; 5) подбронхиальный - от бифуркации трахеи до левого предсердия; 6) ретроперикардиальный (ретрокардиальный) - соответствует проекции левого предсердия и желудочка; 7) наддиафрагмальный - соответствует высоте купола диафрагмы справа; 8) вну- тридиафрагмальный - в самом диафрагмальном отверстии; 9) поддиафрагмальный (абдоминальный) - от диафрагмы до кардии.

Методика рентгенологического исследования пищевода. Пищевод исследуют в прямой, правой и левой косой, боковой проекциях, в вертикальном и горизонтальном положениях. При исследовании в горизонтальном положении достигается тугое заполнение органа на максимально большом протяжении. При тугом заполнении контуры пищевода ровные. Складки слизистой пищевода - 2-3

продольные складки шириной 1-2 мм. Ширина пищевода при тугом заполнении - 2 см. Перистальтика несколькими крупными сегментирующими движениями, как бы выдавливая содержимое.

Методика изучения результатов исследования. При исследовании пищевода изучают: 1) при тугом заполнении - расположение, размеры, форму, контуры, перистальтику, подвижность; 2) при исследовании рельефа слизистой - количество, расположение, диаметр, направление, непрерывность, подвижность складок, а также изменения рельефа в различные моменты перистальтики.

Рентгеносемиотика патологии пищеводасостоит из изменений при тугом заполнении и изменений рельефа слизистой. Изменения при тугом заполнении: смещение, расширение и сужение части или всего органа, неровность контуров, выпадение (отсутствие), ослабление, усиление перистальтики, ригидность стенок, дефект слизистой (ниша), дефект наполнения (опухоль). Изменения рельефа слизистой: расширение или уменьшение калибра складки или складок, извитые складки, складки не моделируются («лысый» рельеф), патологическая перестройка рельефа слизистой, ригидность складки или складок, обрыв складок, изменение направления складок (конвергенция и дивергенция), дефект слизистой (ниша).

Доброкачественные опухоли пищевода: полип, папиллома, аденома, лейомиома, фиброма, ангиома, липома, нейрофиброма, характеризуются медленным ростом и доброкачественным течением, хотя все они могут озлокачествляться.

Лейомиомы - наиболее часто встречающиеся доброкачественные опухоли пищевода, чаще одиночные, редко - множественные. Рентгенкартина: дефект наполнения полуовальной формы с четкими, но неровными контурами при выведении опухоли на контур; веретенообразное расширение пищевода при выведении на рельеф; наличие полушаровидной или полуовальной формы патологической тени на фоне заднего средостения; симптом «перекреста» контуров пищевода; сохраненный рельеф слизистой; эластичность стенок сохранена; редко изъязвляются.

Полипы - по частоте - 2-ое место после лейомиомы пищевода, опухоли, растущие в просвет пищевода, чаще одиночные полипы, по передней стенке, могут быть и множественные. Рентгенкартина: наличие округлого дефекта наполнения с ровными, четкими контурами, чаще до 2 см, и продольной формы дефекта наполнения, обусловленного ножкой при ее наличии; изменение расположения обнаруженного дефекта наполнения в различные фазы исследования или при перемене положения больного; сохраненный рельеф слизистой оболочки вблизи обнаруженного дефекта наполнения и оттеснение, огибание ее складок у места расположения полипа; сохраненная эластичность стенки, на которой располагается обнаруженное образование.

Невриномы встречаются очень редко, растут в просвет пищевода и могут достичь больших размеров, при наличии ножки смещаются вдоль пищевода. Рентгенкартина:

больших или меньших размеров дефект наполнения с четкими и чаще всего ровными контурами, выявить ножку не всегда удается, веретенообразное расширение пищевода, сохраненная эластичность стенок.

Фибромы могут развиваться в наружной оболочке или подслизистом слое стенки пищевода, редко встречаются. Клинически и рентгенологически отличить фиброму от полипа-аденомы невозможно.

Папилломы - редко, одиночные, могут быть и множественными. Рентгенкартина: более или менее крупный дефект наполнения с четкими и довольно ровными контурами, но с неровной поверхностью, склонность к озлокачествлению.

Рак пищевода - составляет 80% от всех заболеваний пищевода, по характеру роста: экзофитный, эндофитный, смешанный, по локализации наиболее часто поражается средняя треть грудного отдела пищевода (40-60%), менее часто опухоль локализуется в нижнегрудном (20-25%) отделе, реже в верхнегрудном (10-15%) отделе. Рентгенкартина: нарушение структуры рельефа слизистой оболочки стенки пищевода, дефект наполнения, сужение просвета или инфильтрация стенки органа, наличие тени опухолевого узла, отсутствие перистальтики пищевода на участке расположения опухоли. Степень выраженности этих признаков зависит от величины и распространения опухолевого процесса по стенке пищевода. При небольших опухолях пищевода дефект наполнения обнаружить нелегко. Поэтому необходимо прибегать к многоосевой рентгеноскопии или к «тугому» выполнению пищевода густой контрастной массой. Нарушение рельефа слизистой оболочки пищевода и отсутствие перистальтики его стенки являются ранними рентгенологическими признаками рака. При распространенном процессе рентгенологически отмечают сужение просвета пищевода до образования узкой ригидной трубки с неровными бугристыми краями и непериальтирующими стенками, вплоть до полного стеноза пищевода с развитием надстенотического расширения органа. При прорастании опухоли в средостение и ее распаде удается проследить нишу, нередко выходящую за пределы стенки пищевода. При образовании пищеводно-трахеального или пищеводно-бронхиального свища бария сульфат при глотании попадает в просвет трахеи или бронха и контрастирует их. Рентгенкартина экзофитной формы рака пищевода: изменение слизистой оболочки - обрыв складок, дефект наполнения с бугристыми контурами, патологическая тень на фоне заднего средостения, локальное сужение просвета, ригидность стенок - аперистальтическая область, супрастенотическое расширение, при изъязвлении - депо бария, нарушение акта глотания при локализации в шейном отделе пищевода, нарушение

функции сфинктеров. Рентгенкартина эндофитной формы рака пищевода: ригидность стенок, сужение пищевода, супрастенотическое расширение, истончение или сглаженность складок слизистой оболочки, утолщение стенки пищевода на ограниченном участке, мелкая зазубренность (изъеденность) контуров пораженного участка.

Компьютерная томография органов грудной клетки проводится для уточнения границ внепищеводного распространения опухоли, позволяет определить наружные контуры пищевода, соотношение его с другими органами средостения (трахеей, бронхами, аортой), более отчетливо контрастировать саму тень опухоли. Компьютерная томография с контрастированием проводится при инфильтрации непарной вены опухолью, выявляется дефект наполнения, неровность контуров ствола вены, сужение ее просвета вплоть до полного блока. Эти симптомы являются абсолютным доказательством внепищеводного распространения опухолевого процесса.

Магнитно-резонансная томография средостения имеет ограниченную диагностическую значимость в связи с перистальтическими артефактами.

Позитронно-эмиссионная томография является методом выбора для диагностики регионарных и отдаленных метастазов, имеет важное значение в стадировании. Диагностическая точность варьирует в зависимости от стадии опухоли.

Тұжырым

Ж.Ж.Жолдыбай

Қазақтың онкология және радиология ФЗИ

Өнеш обырының сәулелік диагностикасы

Мадала өнеш ісіктерінің сәулелік диагностикасына арналған. Өнештің анатомиясы, рентгенологиялық зерттеудің әдістемелері қатарлы және қатерсіз ісіктердің сипаттамалары қолтірілген.

Түйінді сөздер: өнеш, обыр, рентгенологиялық зерттеу.

Summary

Zh.Zh.Zholdybay.

*Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Beam diagnostics tumors of the esophagus*

The article is devoted for the radiology diagnosis of esophageal tumors. It presents the anatomy, x-ray examination methods with a description of the characteristic radiographic aspects of benign and malignant tumors.

Keywords: esophagus, tumor, x-ray,

УДК:616-006-073

А.И. Шибанова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Современная технология и эффективность диагностики опухолей методом клинической цитологии

Аннотация. В работе уточнены возможности современных методов в дифференциальной цитологической диагностике опухолей с использованием ДНК-метрии, цитохимии и жидкостной цитологии.

Ключевые слова: Диагностика, клиническая цитология, ДНК-морфометрия, цитохимия.

Актуальность

Уточняющая морфоцитологическая диагностика приобретает особую актуальность в связи с развитием современной технологии и расширением критериев в клинической цитологии. Для адекватного лечения обязательным условием является детальная идентификация клеток опухоли с установлением степени дифференцировки и злокачественности опухолевого процесса, поэтому внедрение современной технологии в практической деятельности института является актуальным.

Развитие высоких технологий в мире имеет непосредственное отношение для практической медицины в плане лечения и диагностики онкологических заболеваний. Клиническая цитология как классический морфологический метод, устанавливающий гистологические варианты, степени дифференцировки и злокачественности опухолей, представляет собой самостоятельную дисциплину. Сочетание гистологического и цитологического методов является «золотым стандартом» диагностики опухолей, тем не менее, в связи с развитием современных технологий в последние годы возросли требования и возможности к морфологической диагностике опухолевых заболеваний.

В частности, диагностика методом клинической цитологии при установлении варианта опухоли, обязательно дополняется иммуноцитохимическими, морфометрическими данными и определением молекулярно-генетических показателей. Такая подробная верификация опухолевого процесса стала необходимостью для адекватного лечения (подбора химиопрепаратов) и дальнейшего контроля с определением прогноза болезни. При установлении степени злокачественности онкогематологических заболеваний, обязательным является определение фенотипа опухолей методами иммуноцитохимии, иммуногистохимии и проточной цитометрии.

Весьма актуальным в клинической онкологии является выявление ранних форм рака, где существенную роль играет метод флуоресценции при *insitu*гибридизации (FISH), который определяет этапы опухолевой трансформации и может быть дополнительным методом при скрининге населения на онкологические заболевания. В настоящее время для скрининга, на выявление ранних форм рака, используются новые технологии в виде жид-

костной цитологии (ЖЦ) в сочетании с ПЦР, ИФА, FISH и другими методами диагностики.

Цель

- повышение эффективности диагностики опухолей с использованием иммунофенотипирования, ДНК-морфометрии, жидкостной цитологии.

Материал и методы

В последние годы в лаборатории цитологии КазНИИОиР внедряются современные технологии, в частности, впервые в Казахстане, внедрен метод определения ДНК плоидности опухолевых клеток лазерной проточной цитофлуориметрией на аппарате FACSCalibur (BectonDickenson- США). В качестве объекта исследования использовался операционный и биопсийный материал у пациентов с диагнозом рак легкого (60 больных). Для иммунофенотипирования острых лейкозов (40 пациентов) использовалась панель моноклональных антител. Наряду с этим, с 2011 года, в лаборатории внедрен метод ЖЦ (аппарат CytoFast) для диагностики опухолевых процессов в условиях поликлиники и стационара (312 больных). Преимущество метода ЖЦ заключается в улучшении качества фиксации и окраски биоматериала и уменьшении артефактов.

Результаты и выводы. При исследованиях рака легкого в контрольных и опытных образцах были получены DotPlot точечные графики и ДНК гистограммы, определяющие количественное содержание ДНК с выявлением клонов анеуплоидных и полиплоидных клеток при различных вариантах рака легкого.

При исследованиях гемобластозов и лимфопролиферативных заболеваний были установлены варианты В и Т-клеточных принадлежностей острых лейкозов и лимфо-пролифератов.

Метод ЖЦ использован у 312 больных находившихся на обследовании и лечении в КазНИИОиР в том числе у 84 больных получен материал из серозных полостей и смывов, а также при пункциях: у 72 больных - щитовидной железы, у 68 - молочной железы, у 32 - лимфоузлов и др. Предварительный анализ и сопоставление с рутинными методами установили повышение информативности цитологических критериев и улучшение качества диагностического материала до 34 % в зависимости от локализации онкологического заболевания.

Таким образом, использование новых методик в клинической цитологии, при диагностике опухолевых заболеваний, расширяет возможности метода, и является дополнительным критерием для стандарта, как морфо-

логической верификации, так и контроля эффективности лечения и дальнейшего прогнозирования болезни. Метод ЖЦ может быть рекомендован в дальнейшей практической деятельности клинических цитологов для повышения качества диагностики.

Тұжырым

А.И.Шибанова

Қазақтың онкология және радиология ФЗИ

Клиника цитологиялық әдісте обырды тиімді диагностикалау қазіргі заманғы технология.

Жұмыста обыр ауруларды клиникалық, цитология тәсілімен анықталуна жаңа технологияны ендірудің маңызы жоғары екенің көрсетілген.

Түйінді сөздер: Диагностика, клиникалық цитология, ДНК-морфометрия, Цитохимия, цитологиядағы сұйықтық.

Summary

A.I. Shibanova

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Modern technologies and effective diagnosis TUMORS methods of clinical cytology.

The possibilities of modern methods in differential cytologic diagnostics of tumors using the DNA-metry, cytochemistry and fluid cytology were specified in this article.

Keywords: diagnosis, clinical cytology, DNA morphometry, cytochemistry, liquid-based cytology.

УДК: 616.5-006-771

Г.А.Тлеугабылова

Алматинский государственный институт усовершенствования врачей

Диагностика опухолей кожи

Аннотация. По данным онкологической службы республики Казахстан злокачественные новообразования кожи (в том числе меланома кожи) находятся на третьем месте в структуре злокачественных опухолей

Цель исследования - изучение новых возможностей диагностики невусов и опухолей кожи.

Материалы и методы. В работе использованы материалы клинических наблюдений 38 больных. Диагностика невусов и опухолей кожи больных проводилась на аппарате «Дерматоскоп» фирмы Scalar(Япония).

Таким образом, дерматоскопия позволяет оценить изменения, происходящие в тех или иных образованиях кожи при невусах и доброкачественных опухолях кожи, что дает возможность для успешной и своевременной диагностики злокачественных образований кожи. *Ключевые слова:* рак кожи, невус, дерматоскопия.

Актуальность

Рост заболеваемости раком кожи назван «тихой эпидемией» XX века. Рак кожи и меланома - одно из наиболее распространенных в мире онкологических заболеваний, и в ряде стран (США, Австралия) он выходит на первое место [1,2].

На сегодняшний день по данным онкологической службы республики Казахстан злокачественные новообразования кожи (в том числе меланома кожи) находятся на третьем месте в структуре злокачественных опухолей при 10,6% (10,6% - 2009 г.) и продолжают оставаться в «пятерке лидеров» в структуре онкопатологии среди населения. Показатель заболеваемости раком кожи (без меланомы) в 2010 г. составил 17,6%000 (17,5%000-2009 г.). Заболеваемость раком кожи определилась первым рангом в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, в г. Алматы, вторым рангом

- в Карагандинской и Костанайской областях, третьим - Северо-Казахстанской и в Западно-Казахстанской областях [3].

При своевременном обращении к онкологу и адекватном лечении рака кожи на ранней стадии удается полностью излечить 95% больных [1,4]. Учитывая эти обстоятельства, сохраняется актуальность ранней диагностики, профилактики доброкачественных и предопухолевых заболеваний кожи.

В 2001 г. на первой Консенсусной конференции по дерматоскопии (метод визуальной диагностики кожи с помощью видеоаппаратуры с увеличением в 40-80 и в 100 раз) были выработаны соответствующие рекомендации и определены показания для использования разработанных дифференциально-диагностических алгоритмов в клинической практике. Разработанный алгоритм позволил проводить дифференциальную диагностику меланоцитарных и немеланоцитарных, а также злокачественных и

доброкачественных пигментных новообразований кожи по характерным визуальным признакам [5].

По данным ряда исследователей выявлено, что чувствительность дерматоскопии для выявления внутрикожных метастазов составила $75,0 \pm 4,1\%$, а при осмотре через лупу, применяемом при стандартных обследованиях, $26,0 \pm 3,4\%$ ($p < 0,001$) [6,7].

Цель исследования

- изучение новых возможностей диагностики невусов и опухолей кожи.

Материалы и методы

В работе использованы материалы клинических наблюдений 38 больных, находившихся на обследовании и лечении в Казахском НИИ онкологии и радиологии с октября 2011 г. по апрель 2012 г. Диагностика невусов и опухолей кожи больных проводилась на аппарате «Дерматоскоп» фирмы Scalar(Япония). Методика неинвазивна *in vivo*, исследование кожи можно проводить в любых условиях, где есть компьютер или ноутбук. С использованием аппарата «Дерматоскоп» возможно увеличение образований кожи до 100 раз с проведением фото-видео съемки и с последующим архивированием. С помощью данного исследования определяется граница дермы и эпидермиса, сосочковый слой дермы, а также становятся видны пигментация и строение эпидермиса различных образований кожи.

Всем больным была проведена диагностика на аппарате «Дерматоскоп». Первичные злокачественные опухоли кожи были диагностированы у 8 больных (21,1%), из них с метатипическим раком у 1 (12,5%) пациентки, меланомой у 2 (25%), базалиомой у 5 (62,5%) больных. У основного большинства 18 (47,4%) пациентов из 38 диагностированы различные виды невусов кожи, у 4 (10,5%) - себорейный кератоз, у 3 (7,9 %) - дерматофиброма, у 2 (5,3%) - гемангиома, у 3 (7,9%) - диспластический невусный синдром (ДНС).

Больной С, 50 л. аппаратом «Дерматоскоп» диагностирована Меланома плеча слева по 3 основным признакам: 1 - асимметрия образования кожи по форме и пигментации, 2 - бело-голубые структуры, 3 - ромбовидные структуры с кольцевидно-зернистыми формами (рис. 1). Больному Н, 52 л. аппаратом «Дерматоскоп» диагностирована Базалиома кожи носа по 2 основным признакам: 1 - «ветвящиеся сосуды», 2 - бело-голубые пятна (рисунок 2). В обоих случаях диагнозы подтверждены морфологически.

Больной К, 18 л. с помощью аппарата удалось проинвестировать исследование при ДНС с поражением кожи спины, подмышечной области и паховой области. Папилломатозный невус кожи спины (рисунок 3) выставлен с помощью аппарата «Дерматоскоп» на основании 3 признаков: 1 - экзофитные папиллярные структуры,

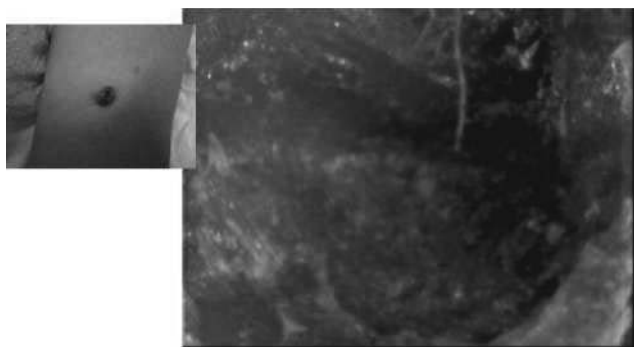


Рисунок 1 - Меланома плеча слева

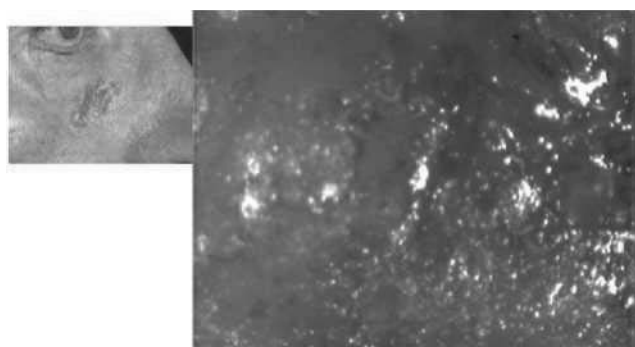


Рисунок 2 - Базалиома кожи носа

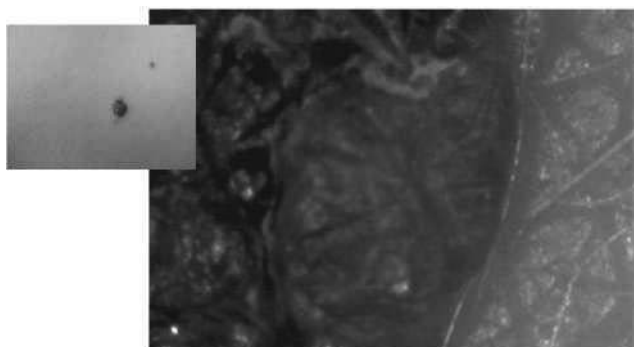


Рисунок 3 - Папилломатозный невус кожи спины

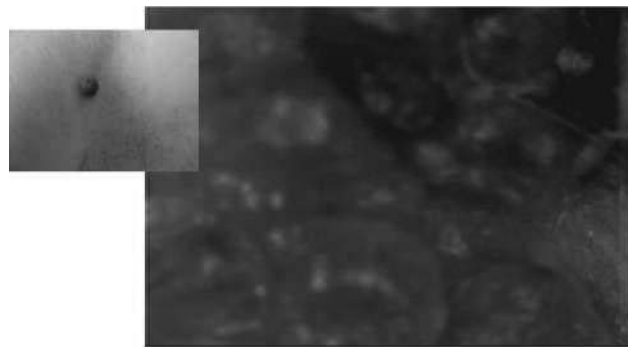


Рисунок 4 - Внутридермальный невус кожи подмышечной области слева

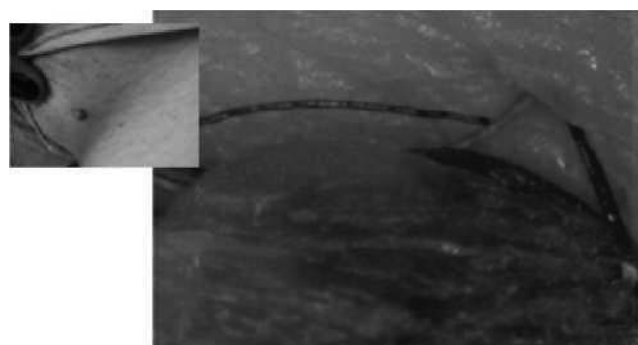


Рисунок 5 - Смешанный невус кожи паховой области справа

2 - камедон подобные отверстия, 3 - милиум-подобные кисты. Подобные образования похожи на меланому. О доброкачественной природе свидетельствует мягкая консистенция и способность сжиматься при надавливании. На рис. 4 видны признаки внутридермального невуса. Заметны участки темно-коричневых пятен и глобул с зонами гипопигментации. В центре имеется бело-голубая структура, представляющая собой пласт меланоцитов. Для исключения меланомы была показано оперативное удаление образования кожи подмышечной области слева с гистологическим подтверждением.

Этой же больной было проведено исследование правой паховой области и дерматоскопической особенностью этого образования явилось наличие экзофитных папиллярных структур, в бороздках гладкой кожи - несколько параллельных пигментированных линий, в центре - скопление темно-коричневых точек и глобул. Избыточная пигментация образования требует проведения дифференциального диагноза с акральная меланомой *insitu*. После оперативного удаления обра-

Выводы

Таким образом, дерматоскопия позволяет оценить изменения, происходящие в тех или иных образованиях кожи при невусах и доброкачественных опухолях кожи, что дает возможность для успешной и своевременной диагностики злокачественных образований кожи.

Список литературы

1. Шенталь В.В., Пустынский И.Н. Рак кожи // РЖО (клиническая). - М.: Медицина., 2001. - № 11. - С. 6.
2. Давыдов М.И., Демидов Д.В., Поляков Б.И. - Основы онкологии: Учебник. - М., 2002. - 240 с.
3. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Аймагамбетова А.Е. Показатели онкологической службы республики Казахстан за 2010 год (статистические материалы). - Алматы, 2011. - 108 с.

4. Давыдов М.И., Демидов Д.В., Поляков Б.И. Современное состояние и проблемы онкологии // Врач. - 2006. - № 13. - С. 3-5.
5. Argenziano G., Soyer H.P., Chimentietal S. Dermatoscopy of pigmented skin lesions: Results of consensus meeting via the Internet // J. Am. Acad. Dermatol. - 2003. - Vol. 48. - С. 679 - 93.
6. Балтабеков Н.Т.. Пути улучшения диагностики и лечения меланомы: дисс. докт. мед. наук. - Алматы, 2009.
7. Фрадкин С.В., Залуцкий И.В. Меланома кожи. - Минск, 2000. - С. 221

Тұжырым

Г.А.Тлеугабилова

Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институты

Тері обырының ерте диагностикасы

Қазақстан Республикасында қазіргі таңда онкология қызметтері терінің қатерлі түзілістері (соның ішінде тері меланомасы) қатерлі обыр құрлымы үшінші орында тұр.

Зерттеу мақсаты – тері обыры және невусты диагностикалаудағы жана мүмкіндіктер.

Әдістер және материалдар. Клиникалық бақылауға

38 науқастың материалы қолданылған. Невус және тері обыры бар науқастарды диагностикалау мына аппаратпен жүргізіледі «Дерматоскоп» фирма Scalar (Япония).

Қатерсіз тері обыры және невустағы терінің өзге немесе өзіндегі түзілімдер, зерттеу көрсеткіштері, дерматоскопияда өзгерістерді бағалауға мүмкіндік береді және қатерлі тері түзілімдерінің заманауи диагностикасы болып табылады.

Түйінді сөздер: тері обыры, неvus, дерматоскопия.

Summary

G.A. Tleugabilova

Almaty State Institute of Advanced Medical

Early Diagnosis of skin tumors

Abstract. To date, according to the Oncology Service of the Republic of Kazakhstan malignant neoplasms of the skin (including melanoma of the skin) are in third place in the structure of malignant tumors.

The purpose of research - the study of new possibilities diagnosis of nevi and skin tumors Materials and methods. The paper benefited clinical observation of 38 patients. Diagnosis of nevi and skin tumors of patients was carried out using the "Dermatoscope" firm Scalar (Japan). The study showed that dermatoscopy to evaluate the changes occurring in the various formations of the skin with nevi and benign tumors of the skin, allowing for a successful and timely diagnosis of malignant tumors of the skin.

Keywords: tumor of the skin, nevi, dermatoscopy.

УДК:616-006.484:615-036.8

С.Б. Бердаuletов, Ш.У. Аязбаев, Р.Р. Шарыгин, К.К. Саргожаев

Мангистауская областная больница, г. Актау

Оценка эффекта терапии анапластических глиом головного мозга

Аннотация. Адекватная оценка эффекта лечения анапластических глиом головного мозга (АГГМ) актуальна и имеет высокую практическую ценность.

Цель исследования – изучение диагностической эффективности компьютерной и магнитно-резонансной томографии и обнаружение продолженного роста в ранний срок после хирургического лечения и лучевой терапии.

Материалы исследования. выполнена КТ, МРТ, диффузно-взвешенная МРТ. Обследовано 19 больных с анапластической астроцитомой (13/68%), глиобластомой (6/31%).

Диагностические возможности МРТ без ДКУ и особенно КТ в обнаружении продолженного роста анапластических глиом головного мозга в ранний период после удаления опухоли, лучевой терапии крайне низкие и непригодны для указанной цели.

Следует ожидать более позитивных результатов от применения протонной МР-спектроскопии.

Ключевые слова: анапластическая глиома головного мозга: диагностика.

Актуальность

Адекватная оценка эффекта лечения анапластических глиом головного мозга (АГГМ) актуальна и имеет высокую практическую ценность.

Смертность от анапластических глиом головного мозга сохраняется на очень высоких показателях и обусловлена многими факторами, среди которых большую роль играют нерадикальное удаление этих опухолей и несвоевременное обнаружение рецидивов и продолженного роста новообразований. Дело дошло до появления гибридных операционных блоков клиник, оснащенных магнитно-резонансными томографами с высокой напряженностью магнитного поля.

Продолженный рост и рецидив анапластических глиом головного мозга диагностируется в относительно поздние сроки после операции и лучевой терапии. Поэтому практическую ценность в уменьшении смертности от анапластических глиом головного мозга имеет обнаружение продолженного роста в ранний срок после хирургического лечения и лучевой терапии.

Цель исследования

- изучение диагностической эффективности компьютерной и магнитно-резонансной томографии и обнаружение продолженного роста в ранний срок после хирургического лечения и лучевой терапии.

Материалы исследования

КТ выполнена на томографе HiSpeedNX/1 GE, МРТ - на МР-системе AchievaPhilips(1,5T) с динамическим контрастным усилением (ДКУ), диффузно-взвешенная МРТ с фактором взвешенности 0; 500; 1000с/мм².
Обследовано 19

больных с анапластической астроцитомой (13/68%), глиобластомой (6/31%). Возраст больных составил от 37 до 62 лет. Мужчин было 11 (57%), женщин - 8 (42%). КТ выполнена всем больным, из них 17 пациентам (57%) - динамическая КТ. Магнитно-резонансная томография использована в 13 (68%) случаях, из которых в двух случаях - без ДКУ. Хирургическая операция по удалению опухоли головного мозга была выполнена 15 (78%) больным с АГГМ и в последующем проведена лучевая терапия, но 4 (21%) больным после операции не была проведена лучевая терапия. КТ и МРТ выполнялись в ранние сроки после удаления АГГМ и завершения лучевой терапии.

Результаты

Ни в одном случае КТ и МРТ в ранние сроки после удаления опухоли не удалось с уверенностью высказать конкретного мнения в отношении наличия или отсутствия остаточной опухоли. КТ-диагностика продолженного роста в течение первых трех месяцев оказалась почти непреодолимой диагностической задачей. Оказалось возможным установить возобновление опухолевого роста у 16 (84%) больных, продолженного роста и рецидива - только в течение последующих 6-12 месяцев в основном благодаря МРТ с ДКУ.

Высказать конкретное мнение о продолженном росте АГГМ в ранний период после операции и лучевой терапии оказалось возможным только после проведения МРТ с ДКУ в 2-х случаях, т.к. диагностические возможности диффузно-взвешенной МРТ весьма скромны.

Выводы

Диагностические возможности МРТ без ДКУ и, особенно, КТ в обнаружении продолженного роста анапластических глиом головного мозга в ранний период после удаления опухоли, лучевой терапии крайне низкие и непригодны для указанной цели в дифференциации так называемых «псевдоответов на терапию», «псевдо прогрессирования АГГМ» при лучевой терапии, «контаминационного» опухолевого отека головного мозга. Диагностические возможности МРТ с ДКУ, DW: (b= 0;500; 1000) в течение первых трех месяцев после удаления АГГМ и лучевой терапии также ограничены.

Следует ожидать более позитивных результатов от применения протонной МР-спектроскопии.

Тұжырым

С.Б.Бердавлетова, Ш.У.Шарыгин, К.К.Саргожаев
Манғыстау облысының ауруханасы, Ақтау қаласы

Бас миының анапластикалық глиом шипасының
нәтижесінің адекваттық сарапшылығы көкейкесті

Бас миының анапластикалық глиом шипасының
нәтижесінің адекваттық сарапшылығы көкейкесті
және биік практикалық бағасы.

Зерттеу мақсаты – сәулел терапиясы және ерте
кездегі хирургиялық емнен кейінгі диагностикалау
тиімділігі компьютерной және магнит-резонанстық
томографияда өсудің артуы табылды. Зерттеу
материалы. КТ орындау, МРТ, диффузно-взвешенная
МРТ. Анапластикалық астроцитомда 19 науқастын
зерттеуі (13/68%) глиобластомой (6/31%). Обырды
ерте алынып тастаған кезеннен кейінгі диагностика
мүмкіндіктері МРТ ДКУ-сыз жасалған, әсіресе КТ-дан
бас миының анапластикалық глиомасының өсуін көруге
болады. Протонды МР-спектроскопия қолданғанда
көбірек тиімді жағымды нәтиже куту тиіс.

Түйінді сөздер: бас миының анапластикалық глио-
масы: диагностика.

Summary

S.B.Berdavletov, Sh.U.Ayazbaev, R.R.Sharygin,
K.K.Sargozhaev

Mangistau regional hospital in Aktau

Adequate assessment of the effect of treatment of ana-
plastic gliomas of the brain relevant

Adequate assessment of the effect of treatment of
anaplastic gliomas of the brain (AGGM) relevant and has
high practical value.

The purpose of research - the study of the diagnostic
efficiency of computer and magnetic resonance imaging
and detection of continued growth in the early period after
surgery and radiotherapy.

Materials research. CT scan, MRI, diffusion-weighted
MRI. The study involved 19 patients with anaplastic
astrocytoma (13/68%), glioblastoma (6/31%).

The diagnostic capabilities of MRI without order, and
especially CT in the detection of the continued growth of
anaplastic gliomas of the brain in the early period after removal
of the tumor, radiation therapy is extremely low and are not
suitable for this purpose.

We should expect more positive results from the use of
proton MR spectroscopy.

Keywords: anaplastic glioma brain: diagnosis.

УДК:616.329-08-059

Ж.А.Арзыкулов, Е.Б.Ижанов, Е.Ш.Абзалбек

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Отдаленные результаты мультимодальной терапии рака пищевода

Аннотация. Представлены непосредственные и отдаленные сравнительные результаты хирургического и мультимодального методов лечения местнораспространенного рака пищевода. Предоперационная полихимиотерапия не ухудшает непосредственные и улучшает отдаленные результаты лечения.

Ключевые слова: рак пищевода, полихимиотерапия, хирургическое лечение.

Рак пищевода занимает шестое место в структуре заболеваемости злокачественными опухолями в мире. Ежегодно в республике выявляется около 1400 больных раком пищевода, а погибает от данного недуга более 1000 человек в год [1].

Лечение рака пищевода остается одной из наиболее сложных проблем современной онкологии. Это обусловлено поздней диагностикой опухолевого процесса, когда доля больных имеющих уже местнораспространенный процесс на момент обращения к врачу составляет 70-80%.

Наиболее радикальным методом лечения рака пищевода является хирургический. Однако этот метод оказывается эффективным лишь при ранних стадиях заболевания. Одной из основных неудач в лечении является большая местная распространенность опухолевого процесса на момент обращения за специализированной помощью. Таким образом, при местно-распространенных опухолях пищевода низкий процент резектабельности не позволяет у большинства больных выполнить радикальное хирургическое вмешательство, то есть применение только лишь одного локального метода воздействия оказывается недостаточным [2,3].

Другим направлением в поиске наиболее оптимального вида лечения рака пищевода является применение предоперационной комбинации лекарственного и лучевого воздействия на опухоль с последующей операцией - мультимодальная терапия [4,5].

Предоперационная химиолучевая терапия рака пищевода приобретает большое значение, так как может быть применена у большинства больных как компонент комплексного метода лечения местнораспространенного процесса. Ее основной целью является увеличение количества радикальных резекций, подавление субклинических метастазов, уменьшение рисков развития отдаленных метастазов и, как следствие, увеличение продолжительности жизни и улучшение результатов лечения в целом.

Отсутствие единого мнения о целесообразности и эффективности проведения предоперационной терапии, методах профилактики послеоперационных осложнений у больных раком пищевода явилось предпосылкой для проведения нашего исследования.

Цель исследования

- улучшение результатов лечения местнораспространенного рака пищевода.

Материалы и методы

В отделении онкохирургии органов ЖКТ Казахского НИИ онкологии и радиологии проведено лечение 107 больных местнораспространенным раком пищевода, из которых 54 больным (основная группа) назначена мультимодальная терапия

неоадьювантная полихимиотерапия (3 курса) + лучевая терапия + операция и 53 пациентам - только хирургическое лечение. Средний возраст больных в группе мульти модального лечения составил $53,5 \pm 25,5$ лет, в группе хирургического лечения - $57,5 \pm 20,51$ лет. Полихимиотерапия проводилась по схеме: доцетаксел – 75 мг/м² 1 день + цисплатин 75 мг/м² 1 день 3 курса с интервалом между курсами 3 недели. Параллельно 3 курсу проводилась лучевая терапия РОД - 2 Гр, СОД - 50 Гр. Последним этапом для мультимодальной терапии выполнялось оперативное вмешательство в объеме субтотальной резекции пищевода с гастрозоофагопластикой со стандартной двухзональной лимфодиссекцией. Данная операция выполнена всем 105 больным.

Результаты и их обсуждение

Во время проведения мультимодальной терапии 2 пациента выбыли из программы лечения в связи с прогрессированием процесса, им произведено оперативное лечение. При проведении неоадьювантной химиолучевой терапии в основной группе эффективность терапии отмечена в 61,5%. Патоморфоз III-IV степени достигнут в 32,7%, I-II

в 57,7%. Токсичность химиолучевой терапии отмечалась I и II степени, за счет эмитических реакций и не лимитировала проведение мультимодальной терапии.

Во всех 105 случаях выполнена субтотальная резекция пищевода. При хирургическом методе лечения у 13 больных из 53 отмечено 15 ($28,4 \pm 0,46$) различного рода осложнений. Среди них наиболее часто встречающиеся осложнения - послеоперационная пневмония (4) ($20,8 \pm 0,24$). В 2-х случаях - летальный исход; в первом случае по причине инфаркта миокарда (1,9%), во втором случае - РДС (1,9%).

В основной группе у 15 из 52 пациентов, отмечено 16 осложнений (30,7%). Превалирующее число осложнений принадлежит послеоперационной пневмонии (9 больных - $17,4\% \pm 0,22$). В данной группе так же отмечена летальность в 2 случаях. В первом по причине РДС (3,8%), во втором - за счет несостоятельности ПЖА (1,9%).

Прослежена годичная выживаемость у 101 из 105

Таблица 1 - Двухгодичная выживаемость больных в группах исследования

Метод лечения	Кол-во больных	Умерло	2-летняя выживаемость	Безрецидивная 2-летняя выживаемость
Хирургический	51	23	28 (54,9 ± 3,65)	24 (47,5 ± 3,55)
Мультимодальный	50	20	30 (60 ± 3,65)	28 (53,8 ± 3,65)

Таблица 2 - Пятилетняя выживаемость больных в группах исследования

Метод лечения	Кол-во больных	Умерло	5-летняя выживаемость	Безрецидивная 5-летняя выживаемость
Хирургический	51	42	9 (18,9 ± 3,80)	8 (17 ± 3,65)
Мультимодальный	50	34	16 (32,7 ± 4,15)	14 (28,8 ± 3,90)

больных, переживших ранний послеоперационный период и пролеченных по сравниваемым схемам. Хирургическую группу составили 51 больной, в группе мультимодальной терапии отслежены ближайшие (2 года) и отдаленные (5 лет) результаты лечения для 50 пациентов.

В таблице 1 представлены данные о двухлетней выживаемости изучаемых групп больных.

Отмечается увеличение количества пациентов, переживших двухлетний срок наблюдения без метастазов и рецидивов при мультимодальном лечении - 53,8 ± 3,65 против - 47,5 ± 3,55 при хирургическом. Аналогично, отмечается увеличение общей выживаемости в группе мультимодального лечения - 60 ± 3,65 по сравнению с 54,9 ± 3,65 при хирургическом.

Пятилетние результаты лечения прослежены также у 101 больного (таблица 2).

В группе хирургического лечения по настоящее время живы 9 (18,9 ± 3,80) человек, в то время как в группе мультимодальной терапии пятилетний рубеж перешагнули 16 (32,7 ± 4,15) пациентов. Безрецидивная пятилетняя выживаемость также выше в группе мультимодальной терапии - 28,8 ± 3,90 против 17 ± 3,65 в группе хирургического лечения. Отмечается снижение темпов смертности после лечения как в группе хирургического, так и в группе мультимодального лечения в сравнении первых двух и последующих трех лет. Так, если в первые 2 года умерло 37,2% и 32% больных в группах хирургии и мультимодальной терапии, то в последующие годы эти цифры составили 31,3% и 30,0% соответственно. Эти показатели соответствуют литературным данным о наибольшем обнаружении прогрессирования опухолевого процесса и смертности пролеченных больных именно в первые два года после радикального вмешательства.

Таким образом, проведение мультимодальной терапии больным местнораспространенными формами рака пищевода не ухудшает непосредственные результаты и улучшает отдаленные результаты лечения.

Список литературы

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д. и др. Показатели онкологической службы республики Казахстан за 2010 год - Алматы, 2011.
2. Altorki N.K., Skinner D. - Occult cervical nodal metastasis in esophageal cancer: preliminary results of three-field lymphnode dissection // J. Thoracic Cardiovasc Surg. - 2001. - Vol. 113, N3. - P. 538-544.
3. Huerbein M., Rau B., Schlag P. Laparoscopy and laparoscopic ultrasound for staging of upper gastrointestinal tumors // Eur. J. Surg. Oncol. - 1999. - Vol. 21. - P. 50-55.
4. Arzykulov Zh., Izhanov E., Utebayeva A. et al. - Evaluation of preoperative chemoradiotherapy in esophageal cancer patients // ESMO. - 13 world congress on gastrointestinal cancer. 2011, Barcelona, Spain.
5. Arzykulov Zh., Izhanov E., Abzalbek E. - Multimodality treatment of locally advanced resectable esophageal cancer // World congress on gastrointestinal cancer- Asian perspectives. - 2012, Shanghai, China.

Тұжырым

Ж.А.Арзыкулов, Е.Б.Ижанова, Е.Ш.Абзалбек

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Өңеш обырының мультимодальды терапиясының
бөлек қорытындысы

Өңеш қатерлі ісігінің жергілікті таралған түрінің оташылдық және мультимодальды күрделенген емінен соң, тікелей және кейінгі нәтижелерінің салыстырмалы түріндегі көрсеткіштері ұсынылды. Оташылдық ем алдындағы жүргізілген полихимиотерапия тікелей нәтижелері еш өзгеріссіз болса, кейінгі көрсеткіштеріше оң әсер етп.

Түйінді сөздер: Өңеш қатерлі ісігі, полихимиотерапия, отаеми.

Summary

Z.A.Arzykulov, E.B.Izhanov, E.Sh.Abzalbek

Long-term results of multimodal therapy of esophageal cancer

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

We present direct and long-term comparative results of surgical and multimodal methods of treatment of locally advanced esophageal cancer. Preoperative polychemotherapy does not impair immediate and improves long-term results of treatment.

Keywords: esophageal cancer, polychemotherapy, surgical treatment.

УДК: 616.23-006-089.5

Б.Т. Мухамадиев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Анестезиологическое обеспечение эндотрахеобронхиальных операций при опухолевом поражении центральных бронхов и трахеи

Аннотация. Целью данного исследования была оптимизация анестезиологического обеспечения эндотрахео- бронхиальных операций по поводу опухолевого поражения центральных бронхов и трахеи.

У пациентов с компенсированной дыхательной недостаточностью (ДН) возможно использование обеих методик — ингаляционной и внутривенной, так как эффективность одинакова. Для предотвращения развития гипоксемии у пациентов с компенсированной ДН целесообразно использование управляемой гипотонии при среднем артериальном давлении 60-70 мм рт. ст. путём непрерывной инфузии пропофола 4-12 мг/кг·ч и изокета 2-6 мг/ч в сочетании с фентанилом 1,9 мг/кгч.

Ключевые слова: ингаляционный, внутривенной наркоз, пропофол, изокет, фентанил.

Известно, что при раке лёгкого (РЛ) доля метастазопродолженных и генерализованных форм опухоли достигает 75% [1,2]. Одной из важных проблем в онкологии является борьба с осложнениями опухоли, одним из которых является синдром обструкции дыхательных путей. Более 40% больных РЛ умирают от осложнений местного характера, а у 20-30% больных низкое качество жизни связано с опухолевым поражением центральных бронхов и трахеи, клинически проявляющимся дыхательной недостаточностью, явлениями обтурационной пневмонии, опухолевой интоксикацией и иными сопутствующими патологическими состояниями [3]. В таких случаях возникает необходимость сохранения и восстановления просвета воздухоносных путей. Особенно актуальна эта проблема у пациентов с декомпенсированной дыхательной недостаточностью (ДН), и первым этапом её решения является выполнение эндотрахеобронхиальных операций (ЭТБО). Важнейшим условием успеха при ЭТБО является методически правильное анестезиологическое пособие, в ходе обеспечения которого решаются 3 основные проблемы: 1) преодоление сложностей при введении в наркоз и интубации; 2) обеспечение адекватной искусственной вентиляции легких; 3) контроль состояния гемодинамики, в частности предотвращение рефлекторного повышения артериального давления.

Таким образом, многие аспекты рационального выбора различных вариантов анестезиологического обеспечения ЭТБО по поводу опухолевого поражения центральных бронхов и трахеи, а именно: реализация вводного наркоза, поддерживающей анестезии, искусственной вентиляции легких остаются нерешёнными и не всегда однозначны,

и требуют дальнейшего изучения.

Цель исследования

- оптимизация анестезиологического обеспечения эндотрахеобронхиальных операций по поводу опухолевого поражения центральных бронхов и трахеи.

Материалы и методы

Материалом для настоящего исследования послужили данные о 42 больных, которым были выполнены ЭТБО по поводу опухолевого поражения центральных бронхов и трахеи в клинике Казахского НИИ онкологии и радиологии в период с 2002 по 2010 гг. Всего мужчин было 83,3% (n=35), средний возраст больных составил 58,4 года. Чаще всего ЭТБО выполняли при плоскоклеточном раке (32) - 76,2% больных, реже при аденокарциномах (10) - 23,8%.

В подавляющем большинстве случаев ЭТБО производили при центральном РЛ (38) - 90,5%, реже при периферических опухолях с централизацией (4) - 9,5%.

По степени выраженности ДН, согласно классификации Л.Л. Шика и Н.Н. Канаева [1,3], декомпенсированная ДН (III степени) была установлена у 7 (16,7%) пациентов, субкомпенсированная (II степени) у 25 (59,5%), а полностью компенсированная — у 10 (25%) пациентов.

Учитывались следующие показания при эндоскопической операции:

- ограниченная опухолевая обтурация трахеи и центральных бронхов;
- гиповентиляция, ателектазы, обтурационные пневмонии, дыхательная недостаточность или угроза кровотечения;
- наличие эндотрахеобронхиального компонента опухоли у больных, которым планируются специальные методы лечения;
- предоперационная подготовка;
- наличие противопоказаний к хирургическому лечению;
- исчерпанность возможностей химиолучевого лечения.

В общей сложности, без каких бы то ни было осложнений проведено 38 ЭТБО (90,5%). Все осложнения были при I—IV степенях стеноза 2 (4,8%) интраоперационных кровотечения; 1 (2,4%) перфорации стенки бронха; 1 (2,4%) — временное нарастание ДН. Летальных осложнений не было. В случае проведения только объёмной ИВЛ средняя продолжительность ЭТБО составила 67 мин (95% С1:35-

ИЮ), при использовании инъекционной высокочастотной ИВЛ - 53 мин (95% СТ.25+75), а сочетанной ВЧИВЛ - 42 мин (95% С1:15-70)($p=0,001$).

Согласно литературным данным, проведение эндотрахеобронхиальных операций более чем в 50% случаев сопряжено с анестезией высокого риска.

В связи с этим, нами был проведен сравнительный анализ эффективности ингаляционной и внутривенной анестезии при интубации у 40 больных 2 групп: с компенсированной и декомпенсированной ДН. Ингаляционную анестезию осуществляли с использованием препарата «севоран»: предварительной преоксигенации потоком чистого кислорода в стандартных дозировках. При внутривенной анестезии миорелаксацией производили введение пропофола в сочетании с фентанилом и аркуроном.

Результаты

Оценка эффективности ингаляционной внутривенной анестезии у больных с декомпенсированной ДН показала, что используемая методика характеризовалась устойчивой тенденцией к нарастанию гиперкапнии. В то же время, применение внутривенной анестезии у этих пациентов продемонстрировало стабильность газообмена. Сравнительный анализ динамики показателей продемонстрировал, что при использовании обеих вариантов наркоза показатель напряжения кислорода в артериальной крови (paO_2), будучи изначально одинаково низким ($56,0 \pm 2,9$ мм рт. ст. $53,0 \pm 3,5$ мм рт. ст., $p=0,4$), после преоксигенации синхронно повышался до $96,0 \pm 2$ мм рт.ст. и $92,0 \pm 4,2$ мм рт. ст. соответственно.

Однако в дальнейшем, на этапе интубации, артериальная гипоксемия при ингаляционной анестезии приближалась к критической ($paO_2 - 51,0 \pm 2,5$ мм рт. ст.), в то время как на фоне внутривенной анестезии значение paO_2 оставалось стабильным и составляло $91,0 \pm 2,7$ мм рт. ст. ($p=0,001$). Аналогичное распределение данных получено и в отношении показателя напряжения двуокиси углерода в артериальной крови ($paCO_2$): в обеих группах этап преоксигенации сопровождался одинаковым уровнем гиперкапнии ($paCO_2=47,0 \pm 4,8$ мм рт. ст. и $47,0 \pm 1,6$ мм рт. ст. соответственно; $p=0,9$). Однако проведение ингаляционной анестезии приводило к ее выраженному усугублению ($paCO_2=61,0 \pm 2,7$ мм рт. ст.), в то время как внутривенная анестезия у всех больных сопровождалась тенденцией к нормализации показателей ($paCO_2 - 45,0 \pm 2,8$ мм рт. ст.), а различия были статистически достоверны ($p=0,005$).

Сравнительный анализ показал, что на фоне ингаляционной анестезии итоговое значение paO_2 было значительно ($p=0,003$) выше, чем при внутривенном наркозе ($140,0 \pm 3,2$ против $110,0 \pm 3,1$ мм рт. ст.). В свою очередь, если при использовании внутривенной анестезии в ходе интубации показатель $paCO_2$ не претерпел существенных изменений, то на фоне ингаляционной индукции он достоверно снизился с $37,0 \pm 1,3$ мм рт. ст. до $31,0 \pm 2,1$ мм рт. ст. ($p=0,01$) как следствие гипервентиляции.

У больных с декомпенсированной ДН на временном интервале 0-30 с, с начала объемной вентиляции легких, средний показатель фотопульсоксиметрической сатурации составил $93,0 \pm 0,9\%$. На этом удовлетворительном уровне ($92,0 \pm 1,1\%$) сатурация оставалась неизменной ($p=0,5$) на всем протяжении первой минуты наблюдения. Аналогичные тенденции прослеживались и для показателя парциального давления углекислоты в конце выдоха ($Pe1CO_2$), который на 30-й секунде составил $39,0 \pm 1,2$, а на 60-й — $42,0 \pm 1,3$ мм рт.

ст., не изменившись ($p=0,4$) на первой минуте проведения объемной ИВЛ.

У больных с компенсированной ДН проведение объемной ИВЛ характеризовалось отсутствием каких-либо проблем с оксигенацией и элиминацией углекислого газа. Показатель $VR0_2$ статистически незначимо ($p=0,4$) изменялся от $97,0 \pm 1,2\%$ до $95,0 \pm 2,1\%$, а $Pe1CO_2$ от $35,0 \pm 0,8\%$ до $37,0 \pm 1,2\%$ мм рт. ст. ($p=0,2$) на протяжении временного отрезка 0-30-60 с, что свидетельствовало о достаточной эффективности методики.

Уровень артериального давления (АД) во время любого хирургического вмешательства отражается на интенсивности кровоточивости и соответственно объеме интраоперационной кровопотери, что особенно важно при выполнении эндоскопических вмешательств, поскольку присутствие в просвете дыхательных путей даже незначительного количества крови, смешанной с мокротой, ограничивает обзор, затрудняет проведение инструментальных манипуляций и нарушает газообмен. Одним из способов контроля интенсивности кровоточивости является коррекция гемодинамики, а именно — селективное снижение артериального давления, т. е. использования методики управляемой гипотонии или гипотензивной анестезии. Реализация концепции управляемой гипотонии возможна в виде нескольких вариантов: 1) ганглионарная блокада пентамином, 2) использование кардиодепримирующих свойств пропофола, 3) использование препаратов из группы нитратов (изокет). Именно последний способ мы считаем оптимальным для достижения этой цели. Важную роль в выборе изокета для гипотензивной анестезии сыграли такие его характеристики, как быстрый период полу выведения (10 мин), достаточно четкий дозо-зависимый эффект и возможность титрования по эффекту, а также небольшое количество осложнений. Применение изокета в сочетании с про- по-фолом позволило использовать невысокие дозы, предотвращающие развитие метгемоглобинемии и синдрома «обкрадывания» коронарных артерий. Методика управляемой гипотонии заключалась в том, что после интубации трахеи производилась оценка динамики уровня АД на введение пропофола в дозе 4-12 мг/кгч. Если не удавалось добиться стабилизации среднего АД (САД) на уровне 60 мм рт. ст., начиналась постоянная инфузия изокета в дозе 1-2 мг/ч.

Изначально уровень САД составлял $99,0 \pm 2,1$ мм рт. ст., однако после интубации в группе управляемой гипотонии этот показатель статистически значимо ($p=0,001$) снизился до $80,0 \pm 2,9$ мм рт. ст., а затем на этапе 5 мин - до $66,0 \pm 4,7$ мм рт. ст. На этапах 10 и 15 мин уровень САД оставался практически неизменным - $64,0 \pm 2,5$ мм рт. ст. ($p=0,5$) и $67,0 \pm 2,4$ мм рт. ст. ($p=0,4$) соответственно. В свою очередь, для группы пациентов с обычным ведением наркоза было характерно достаточно высокое САД (не менее 90 мм рт. ст.) на всем протяжении операции. Применение методики управляемой гипотонии не сопровождалось выраженными изменениями ЧСС, а выход показателей САД за пределы коридора установленных значений (60-65 мм рт. ст.) своевременно корректировался посредством увеличения или снижения скорости инфузии изокета, а также путем введения вазопрессоров или атропина в случае развития брадикардии. Каких бы то ни было, осложнений использования методики не отмечено. У 36,0% больных введения изокета не потребовалось, а уровень систолического АД не превышал 90 мм рт. ст. на фоне обычной инфузии пропофола со скоростью 4 - 12 мг/кгч в сочетании с дискретным введением фентанила из расчета 1,9 /мг/кг-ч. Средний показатель кровопотери

при использовании методики гипотензивной анестезии оказался статистически значимо меньше на 21% ($p=0,002$). Показатели напряжения кислорода при использовании управляемой гипотонии в отличие от обычного ведения наркоза характеризовались стабильностью как в начале, так и в конце основного операционного этапа. Так, в группе больных, у которых проводилась гипотензивная анестезия, среднее paO_2 на начальном этапе ЭТБО было $109,0 \pm 2,5$ мм рт. ст. и в конце основного этапа статистически значимо не снизилось $112,0 \pm 1,6$ мм рт. ст. ($p=0,27$). В то же время, при обычном ведении наркоза paO_2 на начальном этапе ЭТБО составило $114,0 \pm 2,4$ мм рт. ст., а в конце основного этапа значительно снизилось до $87,0 \pm 1,8$ мм рт. ст. ($p=0,0003$). Элиминация углекислоты была удовлетворительной при использовании обеих методик.

Заключение

При выполнении ЭТБО больных с декомпенсированной ДН интубация тубусом ригидного бронхоскопа должна осуществляться в ходе внутривенной индукции с применением быстродействующих миорелаксантов после преоксигенации с последующим, как можно более быстрым устранением критического стеноза. Использование ингаляционного вводного наркоза у этой категории больных нецелесообразно. У пациентов с компенсированной ДН возможно использование обеих методик: как ингаляционной, так и внутривенной, исходя из одинаковой их эффективности. Для предотвращения развития гипоксемии, обусловленной контаминацией кровью дыхательных путей, у пациентов с компенсированной ДН целесообразно использование управляемой гипотонии при среднем артериальном давлении 60-70 мм рт. ст. путём непрерывной инфузии пропофола 4-12 мг/кг-ч и изокета 2-6 мг/ч в сочетании с фентанилом 1,9 мг/кгч.

Список литературы

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеусов Д.М. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы) - Алматы, 2012. --108 с.
2. Мерабишвили В.М. Злокачественные новообразования в мире, России, Санкт-Петербурге. - СПб, 2007. - 422 с.
3. Молчанов И.В., Заболотских И.В., Магомедов М.А. Трудный дыхательный путь с позиции анестезиолога-реаниматолога: пособие для врачей. - Петрозаводск: Интелтек, 2006. -128 с.

Тұжырым

Б.Т.Мухамадиев

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Кеңірдек және орталық бронхтардың обырлық зақымдануы кезіндегі эндотрахеобронхиалды отаға анестезиолог қамысыздандыру

Бұл зерттеудің мақсаты орталық бронх және кеңірдектегі зақымдалған ісікке эндотрахеобронхиалды операция жасау кезінде анестезиологиялық қамтамасыз етудің тиімділігі.

Науқастардың компенсацияланған тынысалу жетіспеуі ішінде әсерлері бірдей болғандықтан, екі әдісті қолданды мүмкін - ингаляция және тамырақылы.

Гипоксемияның өсуін болдырмау үшін компенсацияланған тынысалудың жетіспеушілігі бар науқастарға лайықты ем қолдану, басқарушы гипотония орташа артериялық қысымның 60-70 мм рт. ст. инфузия пропофол 4-12 мг/кг-ч үздіксіз жіберу және изокет 2 мг/ч, фентанилмен қосылып 1,9 мг/кг-ч.

Түйінді сөздер: анестезиолог қамысыздандыру, эндотрахеобронхиалды ота, ингаляционды анестезия.

Summary

B.T.Muhamadiev

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Anesthetic maintenance operations when endotracheal tumor lesions of the central bronchi and trachea

The purpose of this study was to optimize the anesthetic and ensure endotracheobronchially surgery for tumor lesions of the central bronchi and trachea.

In patients with compensated respiratory failure (NAM) is possible to use both methods - intravenous and inhalation, as the effectiveness of the same. To prevent the development of hypoxemia in patients with compensated NAM advisable to use controlled hypotension with a mean arterial pressure of 60-70 mm Hg. Art. by continuous infusion of propofol 4-12 mg / kg-hr and Isoket 2-6 mg / h in combination with fentanyl 1.9 mg / SHM.

Keywords: anesthetic management, endotracheobronchially operation inhalation anesthesia.

УДК: 618.11-006

А.К.Адилышин, Т.М.Пахомова

Северо-Казахстанский облонкодиспансер

«Гигантская киста» яичника

Согласно литературным данным [2], доброкачественные опухоли яичников встречаются в 34% случаев, и по классификации ВОЗ выделяют 11 разновидностей: параовариальные, воспалительные, поверхностные эпителиальные, единичные, множественные и т.д. В доступной литературе мы не нашли описания «гигантских кист» яичников, только Г.С. Мурзабекова с соавт. [3] сообщают о случае дермоидной кисты размерами 15х10х10, весом 1кг 50 г у беременной с беременностью 39 недель, осложнившей течение беременности. Поэтому мы посчитали интересным и полезным для практических врачей изложить наше наблюдение, а также поделиться возможностями дифференциальной диагностики между асцитом и большой кистой брюшной полости на этапе физикального обследования. Основным симптомом этих 2-х состояний является жалоба на распирающую боль в животе и увеличение живота.

Больная Ю.Н.Л., 36 лет, поступила в онкодиспансер 08.06.2009 г. с жалобами на слабость, колюще-распирающую боль в животе. Из анамнеза - осмотрена гинекологом 2 г. назад, вопрос об опухолевом образовании не поднимался. При последнем обращении к врачу в декабре 2008 г. отмечает увеличение живота в объеме, к гинекологам в течение 2-х лет не обращалась. С марта 2009 г. отмечает нарастающую слабость и распирающую боль в животе и в области таза. В областном онкодиспансере обследована амбулаторно, госпитализирована для оказания специализированной помощи. Страдает хроническим пиелонефритом, последние 2 года артериальной гипертензией, перенесла оперативное лечение по поводу панариция на правой ноге; аллергические реакции, гемотрансфузии отрицает. Менструации с 13,5 лет, по 3-4 дня, через 24-26 дней. Гинекологический анамнез - не замужем, беременностей, аборт не было.

Состояние при поступлении средней тяжести, отеков нет, периферические лимфоузлы не увеличены. Кожные покровы и видимые слизистые бледные. Органы кровообращения - тоны сердца приглушены, ритм правильный, систолический шум на верхушке. Пульс 86 ударов в мин, ритмичный. АД - 120/80 мм рт. ст. В легких дыхание жестковатое, в нижних отделах - ослабленное везикулярное, хрипов нет. ЧД - 18 в 1 мин. Органы пищеварения - язык влажный; живот при поверхностной пальпации мягкий, увеличен за счет образования, заполняющего все этажи брюшной полости. Симптом поколачивания поясницы отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное, моча светлая. Стул оформленный, темного цвета.

Гинекологический статус: наружные половые органы без особенностей, invirgo. Perrectum - из таза образование овоидной формы, увеличено до 38 недель беременности, мягкой консистенции, неподвижное, безболезненное при пальпации. Придатки не пальпируются. Своды укорочены. Выделений нет. Предварительный клинический диагноз - Cystoari. Ки-стома яичника. Анемия.

Результаты лабораторного обследования:

а) общий анализ крови - гемоглобин - 55 г/л, эритроциты - $2,5 \times 10^{12}/л$, цп-0,66, тромбоциты - $275,0 \times 10^9/л$, лейкоциты - $4,0 \times 10^9/л$, нейтр. п/яд- 8, сег/яд-58, мон- 1, лимфоциты - 33, СОЭ - 50 мм/час; анизоцитоз - не резко выраженный, пойкилоцитоз - слабо выраженный, гипохромия - не резко выраженная;

б) общий анализ мочи - желт., мут., уд. вес - 1020, кисл., белок - отр., глюкоза - отр., ураты - сплошь;

в) биохимический анализ крови - общий белок - 82 г/л, альбумин - 54,9%, глобулин - 45,1%, из них альфа-1 - 4,3%, альфа-2 - 9,9%, бета - 11,2%, гамма - 19,7%; СРБ-3(+++), мочевины - 5,2 ммоль/л, креатинин - 0,053 ммоль/л, общий билирубин - 11,3 ммоль/л, АлаТ - 0,11 мкмоль/л, АсаТ - 0,11 мкмоль/л, холестерин - 3,5 ммоль/л, глюкоза - 6,1 ммоль/л.

Результаты инструментального обследования:

а) эзофагогастродуоденоскопия - деформация желудка, сдавление извне; дуоденогастральный рефлюкс желчи;

б) ирригоскопия - колит;

в) маммография - без патологии;

г) УЗИ гениталий и брюшной полости - 29.05.2009 г. киста яичника, 02.06.2009 г. по программе «Здоровье» исследованы матка, эндометрий, правый и левый яичники, мочевой пузырь, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки с ЧЛС, селезенка, щитовидная железа. Заключение: структурной патологии не выявлено; 06.06.2009 г. в областной больнице - в поза-дипеченочном пространстве, в боковых отделах и внизу живота - экзонегативные участки, соответствующие свободной жидкости. Заключение: Признаки асцита значительной степени выраженности. 09.06.2009 г. онкодиспансер - в брюшной полости, занимая малый таз, кистозно-солидное образование больших размеров;

д) рентгенография органов грудной клетки - без патологии;

е) ЭКГ - ритм синусовый, синусовая тахикардия, отклонение электрической оси сердца влево. ЧСС-120 в 1 мин. Блокада передней ветви левой н/пучка Гиса; и) МРТ органов брюшной полости - На МР-томограммах определяется кистозное образование больших размеров, расположенное в малом тазу и распространяющееся в брюшную полость до ворот печени, оттесняющее петли кишечника к передней брюшной стенке, гиперинтенсивное на T1ВИ и T2ВИ. Образование имеет капсулу и состоит из нескольких камер, с наличием гиперинтенсивных на T2ВИ включений внутри образования. Печень размерами 152*103*89мм, контуры четкие, ровные, структура однородная. Желчный пузырь размерами 38*24 мм, не деформирован, желчные протоки несколько расширены. Селезенка размерами 138*53 мм, однородной структуры. Положение почек обычное, форма их правильная, контуры четкие, ровные. Заключение: кистозное образование брюшной полости и малого таза.

Консультации специалистов:

а) уролог - без патологии;

б) гематолог - симптоматическая анемия тяжелой степени;

в) терапевт - симптоматическая ЖДА тяжелой степени, миокардиодистрофия, синусовая тахикардия, НЦД по гипертоническому типу, хронический бронхит вне обострения, ДН 0; дуоденогастральный рефлюкс, варикозное расширение вен нижних конечностей;

г) сосудистый хирург - варикозная болезнь, варикозное расширение вен н /конечностей. ХВН 2ст.

17.06.2009 г. произведена нижнесрединная лапаротомия, удаление придатков матки слева, рассечение спаек, дренирование. Свободной жидкости в брюшной полости не обнаружено. При ревизии брюшной полости образование припаяно к передней брюшной стенке, париетальной брюшине, сальнику на всех этажах брюшной полости. Произведена эвакуация жидкости из образования в виде темного кофе в количестве 30,0 литров. Образование отделено от брюшной стенки, петель кишечника, сальника. Образование выделено в рану. При дальнейшей ревизии в верхнем этаже в желчном пузыре выявлен камень, занимающий весь пузырь, плотный. После консультации с зав. хирургическим отделением рекомендовано удаление в общей лечебной сети. Наложены зажимы на воронкообразную связку слева и образование удалено. Матка и правый яичник не изменены. На разрезе образование камерное, стенки ровные, гладкие.

Патолого-гистологическое исследование удаленного образования: в препаратах из левого яичника доброкачественная муцинозная опухоль яичника эндометриального типа; в трубе просвет сужен, полнокровие сосудов, в жировой ткани полнокровные сосуды и участки кровоизлияния.

Цитологическое исследование материала: в содержимом из кисты межфолликулярное вещество, голые ядра, макрофаги.

Послеоперационный период протекал обычно, проводилась патогенетическая адекватная терапия: трансфузии эритроцитарной массы в связи с анемией.

В удовлетворительном состоянии пациентка выписана на амбулаторное лечение по месту жительства под наблюдением гинеколога.

Данный случай соответствует муцинозным эпителиальным опухолям, описываемым Я.В. Бохман [1] - «имеют вид кисты ... часто очень больших размеров ... многокамерные ... имеют ножку».

В качестве физикального метода исследования, дающего возможность различения асцита и кисты брюшной полости мы предлагаем использовать перкуссию с целью определения границы тупости из-за жидкостного образования в горизонтальном положении на спине и на боку, от пупка вбок при положении плессиметра параллельно срединной линии тела, и от пупка вниз к лобку до появления тупости в горизонтальном и вертикальном положении тела [4] при положении плессиметра перпендикулярно к белой линии живота. При наличии свободной жидкости в брюшной полости уровень тупости будет меняться, чего не будет при инкапсулированной жидкости в кистозном образовании.

Список литературы

1. Бохман Я.В. - *Руководство по онкогинекологии*. - М.: Медицина, 1989.
2. Вишневецкая Е.Е. *Справочник по онкогинекологии*. - Минск Беларусь, 1980.
3. Мурзабекова Г.С., Сапарбекова А.З., Мамаева А.М., Осси Н.А. // *Медицинский журнал Казахстана*. - 1999. - №2(5). - С. 95-96.
4. Струтинский А.В. и соавт. *Основы семиотики заболеваний внутренних органов*. - М.: Медпресс-ин-форм, 2011

УДК:616.681-006

Г.А.Серикбаев, Д.А.Тулеуова, А.К.Косаев, Ж.О.Мауленов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Непосредственные результаты хирургического лечения сарком мягких тканей

Аннотация. Саркомы мягких тканей являются относительно редким заболеванием и составляет 2% от всех онкозаболеваний. Наиболее часто встречаются фибросаркомы, злокачественные фиброзные гистиоцитомы, липосаркомы, лейомиосаркомы, синовиальные саркомы.

Ключевые слова: фибросаркомы, злокачественные фиброзные гистиоцитомы, липосаркомы, лейомиосаркомы, синовиальные саркомы.

Цель работы - выработка оптимального объема хирургического вмешательства при злокачественных опухолях мягких тканей.

Обследовано 132 первичных больных со злокачественной опухолью мягких тканей. Всем больным первым этапом проведено хирургическое лечение.

Результат. Объем хирургического вмешательства зависит от стадии заболевания, морфологического строения опухоли, распространенности опухолевого процесса.

Ключевые слова: Саркома мягких тканей, хирургическое вмешательство.

Актуальность

Саркомы мягких тканей являются относительно редким заболеванием. От всех онкологических заболеваний составляет 2%, и 1% в структуре смертности. Наиболее часто встречаются фибросаркомы, злокачественные

Таблица 1 - Гистотип и стадия злокачественных опухолей мягких тканей

№	Нозология	Количество / %	Стадия / %	
			III	IV
1	Фибросаркома	26 / 19,7	24 / 92,3	2 / 7,7
2	Дерматофибросаркома	20 / 15,1	20 / 100,0	
3	Синовиальная саркома	26 / 19,7	25 / 96,1	1 / 4,9
4	Злокачественная фиброзная гистиоцитома	25 / 18,9	22 / 88,0	3 / 12,0
5	Липосаркома	19 / 14,4	19 / 100,0	
6	Рабдомиосаркома	16 / 12,1	15 / 93,7	1 / 6,3
	Всего	132	125 / 94,7	7 / 5,3

фиброзные гистиоцитомы, липо- саркомы, лейомиосаркомы, синовиальные саркомы.

Факторами, ассоциированными с неблагоприятным прогнозом больных саркомами мягких тканей, являются пожилой возраст (старше 60 лет), распространенность опухоли (более 5 см), степень ее злокачественности.

Саркомы мягких тканей - злокачественные, агрессивно текущие опухоли, склонные к развитию отдаленных метастазов и локальных рецидивов. Возникновение рецидивов зависит от объема хирургического вмешательства. После иссечения опухоли рецидивы возникают у 80-90% больных, а после широкого иссечения - только у 10-20%. Поэтому, нерадикальное удаление опухоли является одним из факторов неблагоприятного

Таблица 2 - Осложнения, полученные после проведения различных видов хирургического вмешательства

№	Вид операции	Кол-во / (%)	Осложнения		
			Нагноение (%)	Частичный некроз лоскута (%)	Дыхательно-сердечная недостаточность. (%)
1	Удаление опухоли с резекцией мышц, ребер, перикарда, диафрагмы с пластикой дефекта грудной стенки	12 (ОД)	1 (8,3)	1 (8,3)	2 (16,6)
2	Широкое удаление опухоли (фулярное удаление), с пластикой дефекта и без	95 (71,9)	4 (4,2)	4 (4,2)	
3	Широкое удаление опухоли с резекцией участка артерии, вены с пластикой сосудистым эндопротезом	2 (1,5)			
4	Межподвздошно-брюшная ампутация	4 (3,0)			1
5	Межлопаточно-грудная ампутация	6 (4,5)			1
6	Экзартикуляция суставов (тазобедренный, плечевой)	5 (3,8)			
7	Ампутация(н/ в/конечности)	8 (6,1)			
8	ВСЕГО	132	5 (3,7)	5 (3,7)	4 (3,0)

прогноза заболевания и требует скорейшего широкого иссечения опухоли.

Цель работы

- выработка оптимального объема хирургического вмешательства при злокачественных опухолях мягких тканей.

Материал и методы исследования. За период с 2006 по 2010 годы через отделение опухолей костей и мягких тканей прошло 132 первичных больных со злокачественной опухолью мягких тканей. Из них 26 пациентов с фибросаркомой, 20 пациентов с дерматофибросаркомой, с синовиальной саркомой было 26 больных, 25 больных - со злокачественной фиброзной гистиоцитомой, 20 пациентов - с липосаркомой и 16 - с рабдомиосаркомой. Гистотип опухоли был различен (таблица 1).

Результаты

Всем больным первым этапом проведено хирургическое лечение. Объем хирургического вмешательства отражен в таблице 2.

Широкое удаление опухоли с резекцией участка артерии, вены с пластикой сосудистым эндопротезом проведено наибольшему количеству больных (95) и ни у одного больного не наблюдалось осложнений. Низкий процент осложнений достигнут путем тщательной предоперационной подготовки, коррекцией сопутствующей патологии, выбора оптимального объема хирургического вмешательства.

Вывод

Объем хирургического вмешательства зависел от стадии заболевания, морфологического строения опухоли, распространенности опухолевого процесса.

Тұжырым

Г.А.Серикбаев, Д.А.Тұлеуова, А.К.Косаев, Ж.О.Мауленов

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Жұмсақ тін саркомасының хирургиялық емінiң тiкелей қорытындысы

Бұл зерттеудің мақсаты орталық бронх және кеңірдектегі зақымдалған ісікке эндотрахеобронхиальды операция жасау кезінде анестезиологиялық камтамасыз етудің тиімділігі.

Науқастардың компенсацияланған тынысалу жетіспеуі ілігінде әсерлері бірдей болғандықтан, екі әдісті қолданды мүмкін - ингаляция және тамырақылы.

Гипоксемияның өсуін болдырмау үшін компенсацияланған тынысалудың жетіспеушілігі бар науқастарға лайықты ем қолдану, басқарушы гипотония орташа артериялық қысымның 60-70 мм рт. ст. инфузия пропופол 4-12 мг/кг-ч үздіксіз жіберу және изокет 2-мг/ч фентанилмен қосылып 1,9 мг/кг-ч

Түйінді сөздер: Жұмсақ тін саркомасы, хирургиялық араласулар

Summary

G.A.Serikbaev, D.A.Tuleuova, A.K.Kosayev, Zh.O.

Maulenov

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Short-term results of surgical treatment of soft tissue sarcomas

Soft tissue sarcomas are relatively rare disease, and 2% of all cancers. The most common are fibrosarcoma, malignant fibrous histiocytoma, liposarcoma, leiomyosarcoma, synovial sarcoma.

Purpose - to develop the optimum volume of surgery for malignant soft tissue tumors.

Material and methods. The study involved 132 patients with primary malignant tumor of the soft tissues. All patients first stage underwent surgical treatment.

Results. The surgical procedure depended on the stage of the disease, the morphological structure of the tumor, the prevalence of cancer.

Keywords: sarcoma of soft tissue surgery.

УДК: 618.19-006-08

Г.А.Тлеугабилова, Б.Ш.Кожажметов, Р.Р.Абдулаханова, Ж.Ж.Калиева
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей

Лечение дисгормональных нарушений молочной железы

Аннотация. Применение растительного препарата Мастодион может способствовать достоверному снижению болевого синдрома уже с первой недели терапии. У больных со средней степенью тяжести фиброзно-кистозной, диффузной формой мастопатий эффективность Мастодиона составила 72,5%, а с тяжелой формой - 35,2%. Мастодион является эффективным и безопасным средством для нормализации гормонального баланса при различных формах мастопатий, формирующихся фиброаденом. Полученные результаты свидетельствуют о том, что определены новые пути коррекции дисгормональных нарушений молочной железы. Использование препарата Мастодион открывает новое направление в терапии указанных нарушений - целенаправленно воздействующая терапия. Такая терапия должна стать приоритетной у практических врачей при лечении дисгормональных нарушений молочной железы.

Ключевые слова: опухоли кожи, ранняя диагностика.

Введение

По статистическим данным за последние годы увеличилось число пациенток, обращающихся к специалисту по поводу гиперпластических нарушений молочной железы. Самым распространенным среди них является мастопатия, встречающаяся у 20-40% женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Мастопатию как дисгормональное нарушение впервые описал J. Velpeau в 1838 г.

По определению ВОЗ мастопатия как дисгормональное нарушение характеризуется широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений тканей молочной железы с явлениями эпителиального и соединительнотканного компонентов. Дисгормональные гиперплазии молочных желез, происходящие вне периода лактации и беременности - наиболее распространенные нарушения репродуктивных органов женщины. Молочные железы являются органом-мишенью для половых гормонов яичников, эстроген-гестагенные нарушения играют определяющую роль в регуляции морфологических и гистологических изменений в тканях молочной железы [1].

Рак молочной железы возникает в 3-5 раз чаще на фоне доброкачественных заболеваний молочной железы и в 30-40 раз чаще при некоторых формах узловой мастопатии [2].

За весь репродуктивный период в молочных железах женщины происходит 480 циклов пролиферативных и регрессивных изменений. Нарушение регуляции этих процессов приводит к диффузным перестройкам. Они проявляются в виде диффузных и диффузно-узловых изменений. Различают несколько форм диффузных мастопатий, которые находят свое отображение на

рентгенограммах и при морфологическом исследовании:

- диффузная мастопатия с преобладанием железистого компонента (аденоз);
- диффузная фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ) с преобладанием фиброзного компонента;
- диффузная ФКМ с преобладанием кистозного компонента;
- смешанная форма диффузной ФКМ;
- склерозирующий аденоз [3].

Сейчас уже известны молекулярные механизмы, приводящие к развитию пролиферативных процессов в молочных железах. Среди них можно выделить три основных внутриклеточных механизма. Это: 1) гормональный (или эстроген-зависимый) путь; 2) путь, индуцируемый ростовыми факторами; 3) путь, активируемый противовоспалительными цитокинами. Многолетние поиски природных соединений, блокирующих развитие гиперпластических процессов в гормон-зависимых тканях, наконец, увенчались успехом. Одним из таких препаратов растительного происхождения является Мастодион. К основным фармакологическим эффектам препарата относится: нормализация метаболизма эстрогенов, блокада сигнальных путей, индуцированных ростовыми факторами и цитокинами [4,5].

Цель исследования

- изучение новых возможностей терапии Мастодионом при дисгормональных нарушениях молочной железы.

Материал и методы

Комплексно обследовано более 30 женщин. Обследование включало клинический осмотр, маммографию, ультразвуковое исследование, осмотр гинеколога, консультацию эндокринолога.

Выделены группы больных с различными формами фиброзно-кистозной мастопатии (ФКМ) (N=30) в возрасте от 18 до 67 лет со следующими нозологическими формами:

- выраженная ФКМ с преобладанием кистозного компонента - 10 (33,3 %);
- выраженная ФКМ с преобладанием фиброзного компонента - 8 (26,6 %);
- диффузная мастопатия с преобладанием железистого компонента (аденоз) - 8 (26,6 %);
- формирующаяся фиброаденома - 2 (6,6 %);
- внутрипротоковые образования - 2 (6,6 %) на фоне ФКМ.

22 (73,3 %) больных предъявляли жалобы на боли (масталгии) в молочных железах. Уплотнение в молочных железах пальпировалось у 14 (46,6%), сопутствующая патология - у 18 (60 %). Сопутствующие заболевания включали миому матки - 2 (6,6 %), эндометриоз - 3 (10%), хронический аднексит, спаечный процесс в малом тазу - 6

(20 %), тиреоидит - 11 (36,6 %), узловой зоб - 4 (13,3%).

При рентгенологическом исследовании у больных с выраженной ФКМ с преобладанием кистозного компонента на фоне железистой гиперплазии и умеренного фиброза стромы имеются множественные округлые и овоидные образования различной величины от 0,5 до 4-6 см с четкими ровными контурами.

Рентгенологическая картина смешанной формы мастопатии характеризуется перестройкой структуры железистой ткани с наличием множественных участков затемнения и просветления различной формы и величины. На фоне диффузной перестройки могут выделяться отчетливые тени отдельных кист. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) диаметр кист колебался от 0,7 до 4 см с четкими ровными контурами.

Рентгенологически склерозирующий аденоз определяется участками гиперплазии железистой ткани в виде нерезко очерченных очагов уплотнения, чаще округлой формы. При УЗИ узловых образований выявлено не было.

В 6,6% при подозрении на внутримолочные образования проводилось цитологическое исследование серозных выделений из сосков молочной железы. У больной К., 55 лет в анамнезе 22 года назад была фибросаркома левой лопатки. Состояние после краевой резекции лопатки с опухолью и лучевой терапии. (Гистологическое заключение № 4500-4522 от 15.03.89. - дифференцированная фибросаркома). У этой же больной 2 года назад была произведена секторальная резекция левой молочной железы по поводу склерозирующего аденоза. В 12% случаев при подозрении на рак проводилась пункционная биопсия с цитологическим исследованием. Больным с сопутствующими заболеваниями проводилось дополнительное обследование, включающее анализ крови на гормоны (ТТГ, Т3, Т4, ЛТГ, ФСГ, эстрадиол, прогестерон и пролактин), УЗИ щитовидной железы, яичников, гинекологическое обследование. У 8,2% пациенток было повышенное содержание эстрогена в крови, 3,4% - повышение уровня Т3 гормона щитовидной железы.

Результаты и обсуждение

Мастодином назначался 30 больным с мастопатией, фиброаденозом, формирующейся фиброаденомой по 1 таблетке 2 раза в день в течение 3 месяцев с обязательным дополнительным лечением сопутствующей патологии и динамическим контролем.

Через 3 месяца пациентам был проведен контроль, включающий клинический осмотр, маммографию (женщинам старше 35 лет), УЗИ (до 35 лет) и дополнительное обследование больных с сопутствующей патологией (анализ крови на гормоны, УЗИ щитовидной железы, яичников, гинекологический осмотр).

После 3-х месячного курса лечения в ходе комплексного обследования получены следующие

Таблица 1 - Показатели субъективных данных при дисгормональных нарушениях молочной железы до и после лечения Мастодином (n= 30)

Клинические симптомы	До лечения		После лечения	
	абс.	отн., %	абс.	отн., %
Масталгия	22	73,3	18	81,8
Нормализация менструального цикла	8	60	6	75
Примечание: 0,001 < p < 0,01				

результаты. У больных со средней степенью тяжести фиброзно-кистозной, диффузной формой мастопатий эффективность Мастодиона составила 72,5%, а с тяжелой формой - 35,2%. У 18 (81,8%) больных из 22, страдавших масталгией до лечения, исчез болевой синдром, чувство тяжести, жжения в груди после первой недели терапии, прекратился дискомфорт в молочных железах в предменструальном периоде. У 6 (75%) пациенток из 8 отмечалась нормализация менструального цикла (Табл.1)

При контрольном обследовании 30 пациенток через 3 месяца после начала лечения отмечался положительный эффект в ультразвуковой и рентгенологической картине. Результаты динамического и маммографического и УЗИ наблюдения пациентов с различными формами фиброзно-кистозной мастопатии представлены в таблице 2.

Как видно из представленной таблицы, положительная динамика отмечалась у 19 (63,3%) пациенток из 30 при комбинированном лечении дисгормональных нарушений молочной железы Мастодином и сопутствующих заболеваний щитовидной железы, яичников. Положительная динамика заключалась в уменьшении плотности железистого и фиброзного компонента за счет снижения объема гиперплазированных элементов, не возникали новые узловые образования. При контрольных динамических УЗИ исследованиях был отмечен регресс кист: уменьшение их количества и диаметра, а также их исчезновение, уменьшение диаметра протоков. У 2 пациенток на фоне лечения Мастодином и лечения патологии со стороны щитовидной железы и яичников отмечалось полное рассасывание формирующихся фиброаденом. У 1 пациентки на фоне лечения Мастодином и удаления кисты яичника отмечалось полное рассасывание внутримолочного образования молочной железы.

Стабилизация процесса отмечалась у 11 (36,7%) пациентов, которым проводилось лечение только Мастодином, без лечения сопутствующей патологии (по тем или иным причинам не выполняли назначения эндокринолога и гинеколога). Стабилизация процесса выявлена у 4 (40%) с ФКМ с преобладанием кистозного компонента, у 3 (37,5%) с ФКМ с преобладанием фиброзного компонента и также у 3 (37,5%) с диффузной ФКМ с преобладанием железистого компонента.

Ни в одном случае не отмечалось ухудшения состояния молочных желез. Побочные эффекты при приеме Мастодиона не наблюдались.

Таблица 2 - Показатели объективных данных при дисгормональных нарушениях молочной железы на фоне консервативной терапии (по данным маммографии и УЗИ исследования)

Формы ФКМ	Положит. динамика		Стабилизация процесса	
	абс.	отн., %	абс.	отн., %
ФКМ с преобладанием кистозного компонента n= 10	6	60	4	40
ФКМ с преобладанием фиброзного компонента n= 8	5	62,5	3	37,5
Диффузная ФКМ с преобладанием железистого компонента n= 8	5	62,5	3	37,5
Формирующаяся фиброаденома n= 2	2	100	0	0
Внутримолочные образования n= 2	1	50	1	50
Всего	19	63,3	11	36,7
Примечание: 0,001 < p < 0,01				

Выводы:

У больных со средней степенью тяжести фибронокистозной, диффузной формой мастопатий эффективность Мастодиона составила 72,5%, а с тяжелой формой - 35,2%.

У 18 (81,8 %) больных из 22, страдавших масталгией до лечения, исчез болевой синдром после первой недели терапии, у 6 (75%) пациенток из 8 отмечалась нормализация менструального цикла

Положительная динамика отмечалась у 19 (63,3%) пациенток из 30 при комбинированном лечении дисгормональных нарушений молочной железы Мастодином и сопутствующих заболеваний щитовидной железы, яичников.

Стабилизация процесса отмечалась у 11 (36,7%) пациентов, при лечении только Мастодином, без терапии сопутствующей патологии, у 4 (40%) с ФКМ с преобладанием кистозного компонента, у 3 (37,5%) с ФКМ с преобладанием фиброзного компонента и также у 3 (37,5%) с диффузной ФКМ с преобладанием железистого компонента.

Эффект при применении Мастодиона достигает от 3 до 6 месяцев, что зависит от формы мастопатии и от размера формирующихся фиброаденом, также связано с глубинными механизмами воздействия на регуляцию гормонально-метаболических процессов в организме.

Список литературы

1. Практическая маммология. Под редакцией М.И.Давыдова, В.П.Летягин - Практическая медицина. - М., 2007.
2. Черенков В.Г. Клиническая онкология. - М., 2005. - С. 187-189.
3. Зотов А.С., Белик Е.О. Мастопатия и рак молочной железы. - М., 2005.
4. Джубалиев С.К., Пак Д.Д. Лечение рака и доброкачественных заболеваний молочной железы. - Казань, 2004. - С. 106-110.
5. Бурдина Л.М., Бурдина И.И. Мастодион и его роль в лечении доброкачественных заболеваний молочных желез // Маммология. - 1998. - №3. - С. 72-79.

ТҰЖЫРЫМ

Г.А.Тлеугаблова, Б.Ш.Кожаметов, Р.Р.Абдулаханова, Ж.Ж.Калиева

Сүт безінің дисгормональды бұзылыстының

Алматылы Мемлекеттік дәрігерлерді жетілдіру институты

Препарат Мастодионды қолдану терапияның алғашқы аптасынан-ақ ауыру синдромын анық түрде азайтуға септігін тигізеді. Мастодионның тиімділігі мастопатияның фиброз-кистозды және диффуздық калпының орта ауырлығы бар пациенттер арасында 72,5% құраса, ауырлығы жоғары формаларында 35,2% құрады. Мастодион мастопатияның түрлі калыптарындағы гормональді нормалайтын тиімді де қауіпсіз құрал болып табылады. Алынған нәтижелер сүт безінің дисгормональды бұзылуларын түзейтін жаңа тәсілдер табылғандығын көрсетеді. Мастодион препаратын қолдану аталып кеткен бұзылулар терапиясында, яғни мақсатты әрекетететін терапияда жаңа бір бағыт ашады. Сүт безінің дисгормональды бұзылуларын емдеуде дәрігерлер практикасында бұндай терапия басты бағыт болуы қажет.

Түйінді сөздер: сүт безі, мастопатия, Мастодион.

SUMMARY

Tleugabilova G.A., Kozhahmetov, B.Sh., Abdulahanova R.R., Kalieva Z.Z.

Almaty State Institute of Advanced Medical Treatment of violations of breast cancer

Using of vegetable preparation Mastodinon could contribute to reliable reducing of pain syndrome from the first week of therapy. Efficiency of Mastodinon is 72.5% among the patients with medium-scale of severity of fibro-polycystic and diffusive forms of mastopathy, and 35.2% among the patients with heavy-scale forms of mastopathy. Mastodinon is efficient and safety remedy for normalization of hormonal balance in different forms of mastopathy, which shapes (forms) from fibroadenomas. Getting results indicates new ways of correction disharmonic imbalances of mammary gland. Using of preparation Mastodinon opens new direction in purposive actuating therapy. That kind of therapy should be preemptive in treatment of disharmonic imbalances of mammary gland among practical doctors.

Keywords: breast, breast, Mastodinon.

УДК: 616.661-006-08

Е.И.Ишкинин, В.Б.Ким, М.А.Ибраимова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Применение лучевой терапии и бисфосфонатов для паллиативной помощи пациентам с метастатическим поражением костей скелета при раке почки

Аннотация. Почечно-клеточный рак относится к агрессивным и непредсказуемым в своем течение злокачественным опухолям, часто осложняется метастатическим поражением костей скелета. При облучении пораженных участков может достигаться временная остановка роста опухолевого узла и уменьшение тягостных проявлений болезни. Лечение лучевой терапией в сочетании с бисфосфонатами ингибирует на длительное время костную резорбцию. Произведена оценка непосредственной эффективности лучевой терапии, частота лучевых реакций, оценка качества жизни у пролеченных пациентов, отдаленные результаты у пролеченных пациентов. С использованием лучевой терапии и бисфосфонатов нам удалось достичь цели улучшения качества жизни этих крайне тяжелых больных.

Ключевые слова: рак почки, метастазы, лучевая терапия.

Актуальность

В процессе метастазирования, опухолевые клетки через кровь и лимфатические сосуды могут проникать в любые органы и ткани, в том числе в костную ткань. Когда раковые клетки проникают в кость, они влияют на все функции, впоследствии вытесняют здоровые клетки, нарушают взаимодействие между остеокластами и остеобластами, тем самым разобщая их работу. Метастазы в кости могут выявляться в любой части скелета, чаще всего костные метастазы локализуются вблизи позвоночника, среди других участков скелета - это тазовая кость, бедренная, плечевая, ребра и череп. Для больных с солидными опухолями метастазы распространяются преимущественно по оси скелета, что в основном отражает особенности распределения красного костного мозга. Развитие костных осложнений существенно снижает качество жизни больных с костными метастазами, инвалидизируя и причиняя страдания больным, отягощая течение их заболевания и препятствуя продолжению специфического противоопухолевого лечения, в итоге снижая их продолжительность жизни. Однако у пациентов с костными метастазами продолжительность жизни значительно выше (30 месяцев) по сравнению с пациентами с висцеральными метастазами (11,6 месяцев) [1]. Своевременное лечение костных метастазов снижает частоту возникновения новых очагов костного метастазирования, увеличивает выживаемость больных, существенно улучшает качество жизни этих больных за счет снижения частоты скелетных осложнений: болевого синдрома, патологических переломов, компрес-

сии спинного мозга, гиперкальциемии. Очень редко метастатическое поражение костей бывает бессимптомным.

Лучевая терапия может оказать паллиативный эффект при костных метастазах при суммарной дозе в 30 - 35 гр, даже если боль не проходит, то у 80 - 90% больных быстро снижается ее интенсивность [2]. Полное исчезновение боли наблюдается у 20-50% больных, частичное у 50- 80% (уровень доказательности 1а). Положительный эффект наступает в сроках от нескольких дней до 4 недель. Продолжительность положительного эффекта может достигать 3- 6 месяцев. [3,4,5]. Однако у таких пациентов предпочтительнее применение мультифракционированных режимов (10 сеансов по 3 гр), поскольку они предполагают введение более высокой дозы и, таким образом, существенное уменьшение размера опухоли [6,7] (уровень доказательности 2а). Высокие дозы лучевой терапии с паллиативной целью при болезненных костных метастазах оказались эффективными у 50- 75% всех больных с почечно-клеточным раком, и у 67% пациентов с костными метастазами вообще [8] (уровень доказательности 2b). Уменьшение в размерах опухоли и предотвращение выделения химических медиаторов боли - основные механизмы, определяющие уменьшение боли после лучевой терапии (уровень доказательности 3). Снижение интенсивности боли вероятнее всего связано с уменьшением количества воспалительных клеток, которые представлены в микроокружении костных метастазов, под действием ионизирующей радиации и ингибирования выделения медиаторов боли [9,10] (уровень доказательности 3). В целях уменьшения боли при метастазах в кости однофракционная ЛТ столь же эффективна, как и мультифракционная, однако частота повторного лечения и переломов выше при однофракционном режиме [4,11] (уровень доказательности 1а).

Патогенез усиленной костной резорбции обусловлен нарушениями нормального механизма костеобразования. В основе его лежит активизация резорбтивных процессов в костной ткани вследствие «регулирующего» влияния метастатических клеток. Этот факт послужил основанием для изучения возможностей использования лекарственных препаратов с лечебной целью, которые обладают способностью оказывать влияние не столько на метаболизм самой опухоли, сколько на костный обмен, нарушенный опухолевым процессом. Костные метастазы плохо реагируют на иммунотерапию, и в отношении последней нет доказанных данных по купированию боли. Гормональная терапия и химиотерапия еще менее эффективны и не могут занять место в лечении болевого синдрома [12]. Бисфосфонаты снижают активность остеокластов, что в результате приводит к подавлению резорбции костной

ткани. Кроме того, в ряде исследований показана способность бисфосфонатов потенцировать противоопухолевый эффект цитостатиков, гормонов и лучевой терапии [13,14]. Они оказывают лечебное действие при болевом синдроме, гиперкальциемии, а также позволяют предупреждать их появление, патологических деформаций, переломов, обеспечивают улучшение качества жизни этой категории больных.

Основные эффекты терапии бисфосфонатами:

Уменьшение риска осложнений со стороны костной системы, анальгетический эффект - у 60-85% пациентов (уровень доказательности 1b) [15,16,17].

Несмотря на то, что предлагаемое лечение не является собственно цитотоксическим и не направлено непосредственно против раковых клеток - это один из реальных путей повышения качества жизни пациентов.

Цель

Повышение эффективности паллиативного лечения больных раком почки с метастатическим поражением костей скелета.

Задачи

- Проанализировать непосредственную эффективность лучевой терапии при раке почки с метастатическим поражением костей скелета, частоту лучевых реакций, оценку качества жизни у пролеченных пациентов.

- Определить общую выживаемость и медиану выживаемости у пролеченных пациентов.

- Произвести сравнительную характеристику выживаемости у пациентов получавших и не получавших бисфосфонаты.

- Оценить возможные факторы риска смерти у пролеченных больных.

Материалы и методы

Было проведено ретроспективное исследование историй болезни 20 пациентов раком почки с метастатическим поражением костей скелета, у которых проведена паллиативная лучевая терапия (ЛТ) в отделении радиационной онкологии (ДЛТ1) Казахского НИИ онкологии и радиологии МЗ РК за период с 2006 по 2011 гг. Возраст пациентов на момент лечения составил от 31 до 68 лет, медиана 55,1 год, 12 мужчин и 8 женщин. В 12 случаях - поражение опухолью правой почки и в 8 случаях - поражение левой почки. Во всех случаях первым этапом специализированного лечения была проведена нефрэктомия. Адювантную иммунотерапию получили 5 пациентов, адъювантную полихимиотерапию (от 1 до 4-х курсов) получили 4 пациента, дистанционная ЛТ на область ложа почки была проведена 1 пациенту. С момента выполнения нефрэктомии до начала паллиативной ЛТ на выявленные в костях скелета метастатические очаги, прошло от 1,5 до 14,5 месяцев (медиана 6,4 месяца). Гистологической формой опухоли во всех случаях являлся почечно-клеточный рак (светлоклеточный вариант - 13; папиллярный вариант - 3; хромофобный вариант - 3; саркоматозный вариант - 1), верифицированный при нефрэктомии. Всем пациентам при поступлении было проведено стандартное клинкорентгенологическое обследование: УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, рентгенологическое подтверждение метастатического поражения костей скелета, скинтиграфия костей скелета. Среди 20 пациентов с рентгенологическим подтверждением (обзорная

рентгенография, КТ, МРТ) поражение костей скелета выглядело следующим образом: 16 случаев - метастатическое поражение позвоночника (грудной отдел - 10 пациентов, поясничный отдел - 5 пациентов, шейный отдел - 1 пациент), поражение ребер, лопатки, грудины, теменной кости черепа, кости таза - по 1 пациенту. Облучение пациентов проводилось на гамматерапевтическом аппарате «Teragam» и линейном ускорителе электронов «Gipac 600C/D». Разовая очаговая доза (РОД) составила от 2,5 Гр до 5,0 Гр, 3-5 Фр в неделю до суммарной очаговой дозы (СОД) от 30 до 50 Гр. 10 пациентам была произведена инфузия бисфосфонатов: 6 пациентам - препарат золедроновой кислоты (зомета 4 мг), 4 пациентам

препарат клодроновой кислоты (бонефос 1500 мг). Общая выживаемость (OS- overall survival) рассчитывалась от начала ЛТ до смерти от любой причины или до даты последней явки пациента. Создание базы данных осуществлялось в программе Microsoft Excel. Статистическая обработка материала производилась на персональном компьютере при помощи программы математической обработки данных SPSS Statistics версия 17,0. Построение кривых выживаемости производилось по методике Kaplan Meier [18]. Сравнение кривых выживаемости проводилось с помощью Logrank теста. Результаты. На момент поступления у всех 20 пациентов отмечался болевой синдром в области метастатического поражения, 5 пациентов с признаками патологического перелома. У 14 пациентов - невозможность самостоятельного передвижения. Продолжительность госпитализации составила от 13 до 35 койко-дней (медиана - 23,6 к/д). Общий объективный эффект после окончания лучевой терапии достигнут у 19 больных (95%). При контрольном осмотре через 2 недели у них был выявлен положительный клинический эффект - отмечалось уменьшение интенсивности, продолжительности и остроты болевого синдрома. У одного пациента при дозе лучевой терапии СОД 30 Гр не наблюдался положительный эффект. Переносимость терапии была удовлетворительной, лишь у 20% больных были осложнения в виде анемии и тромбоцитопении. Проявление гематологической токсичности IV степени отмечено не было. Побочные эффекты являлись в основном преходящими, купирующимися в течение нескольких дней, включающих в себя: усиление боли в течение 12 часов (вследствие отека), симптомы возникновения которых обусловлены зоной облучения и локализацией метастазов, тошнота (особенно при больших полях облучения позвоночника), диарея, раздражение горла и зозофагит.

Общая выживаемость пролеченных больных (рис. 1) составила 40%, медиана выживаемости 10,9 месяцев. При этом отмечается интересный факт того, что при выживании свыше 11 месяцев не было отмечено смертных случаев. В настоящее время 6 пациентов перешагнули этот рубеж.

Проведен анализ зависимости выживаемости у пациентов, получавших и не получавших бисфосфонаты в процессе лечения (рис. 2). Общая выживаемость у 10 пациентов, получивших бисфосфонаты, составила 50%, медиана выживаемости - 12,1 месяцев, для сравнения у 10 пациентов, не получивших бисфосфонаты, общая выживаемость составила 30%, медиана выживаемости 3 месяца.

При анализе групп пациентов по факту получения после нефрэктомии адъювантной терапии (рис. 3), мы наблюдаем, что выживаемость выше у группы больных получивших адъювантную терапию (10 пациентов), чем у группы пациентов, не получивших адъювантную терапию (общая выживаемость 50% и 30% соответственно). При

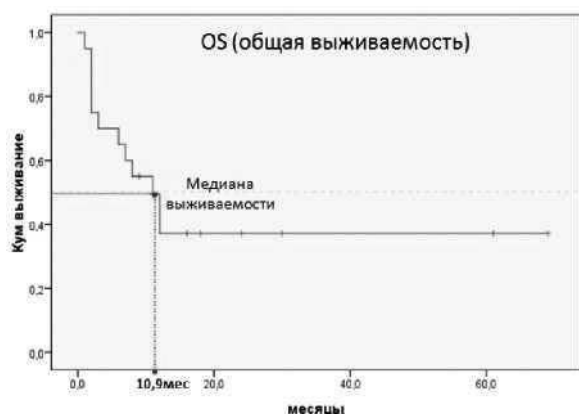


Рисунок 1 - Общая выживаемость пролеченных больных

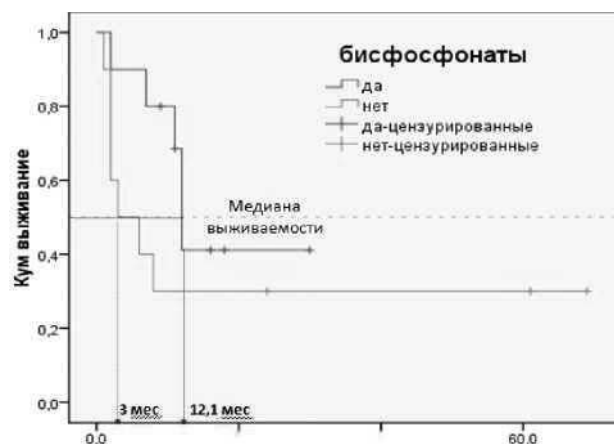


Рисунок 2 - Выживаемость в зависимости от получения бисфосфонатов

этом медианы выживаемости сопоставимы.

Однако при стратификации пациентов по факту получения адъювантной терапии (рис. 4), в группе пациентов, получивших бисфосфонаты, медиана выживаемости выше, по сравнению с пациентами, не получившими бисфосфонаты (11,7 месяцев и 6,2 месяцев соответственно). В группе пациентов, не получавших бисфосфонаты, медиана выживаемости выше у пациентов которым была проведена адъювантная терапия (6,2 и 3 месяцев соответственно).

Интересные результаты получены у групп пациентов, разделенных по половому признаку, по стороне поражения почки, и наличия поражения какого-либо отдела позвоночника (рис. 5,6,7). Учитывая низкие показатели выживаемости (таблица 1), можно предположить, что факторами риска являются принадлежность к мужскому полу, поражение опухолью правой почки и поражение позвоночника, однако эту закономерность необходимо проверить на большем числе пациентов.

Функции дожития

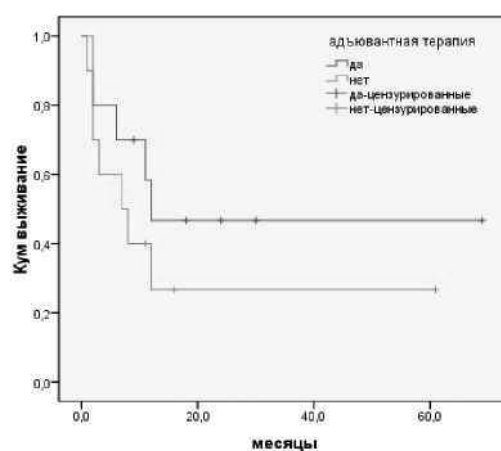


Рисунок 3 - Выживаемость в зависимости от проведения адъювантной терапии

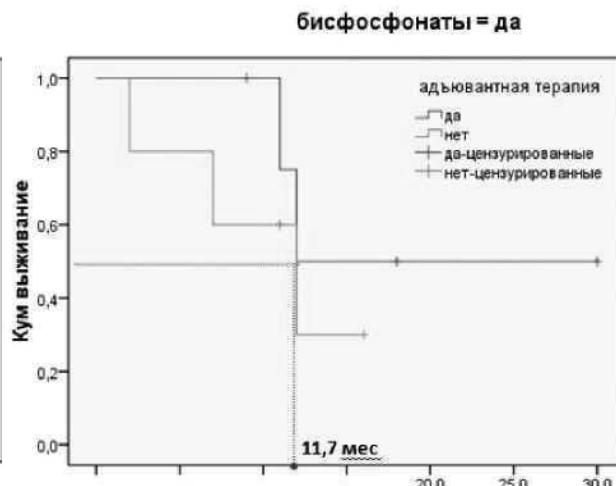
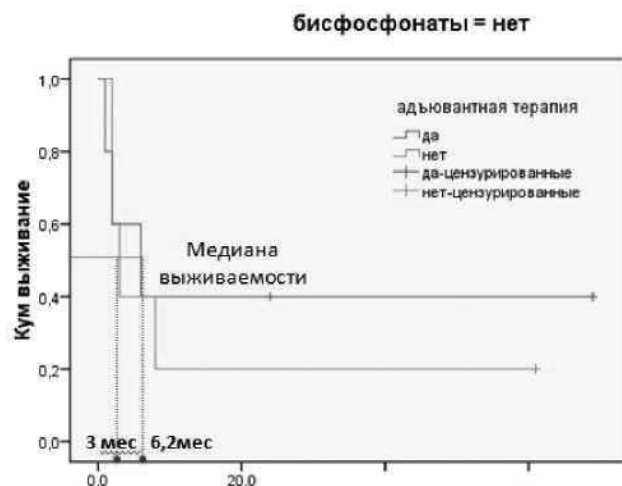


Рисунок 4-5 - сравнение групп пациентов получивших бисфосфонаты с не получившими бисфосфонаты, при проведении или не проведении у них адъювантной терапии

Интересные результаты получены у групп пациентов, разделенных по половому признаку, по стороне поражения почки, и наличия поражения какого-либо отдела позвоночника (рис. 5,6,7). Учитывая низкие показатели выживаемости (таблица 1), можно предположить, что факторами риска являются принадлежность к мужскому полу, поражение опухолью правой почки и поражение позвоночника, однако эту закономерность

Обсуждение

Почечно-клеточный рак относится к агрессивным и непредсказуемым в своем течение, злокачественным опухолям. У 33% больных рак почки диагностируется впервые уже в диссеминированной стадии. Из оставшихся 67% почти у половины развиваются отдаленные метастазы в течение 5 лет после радикального хирургического лечения

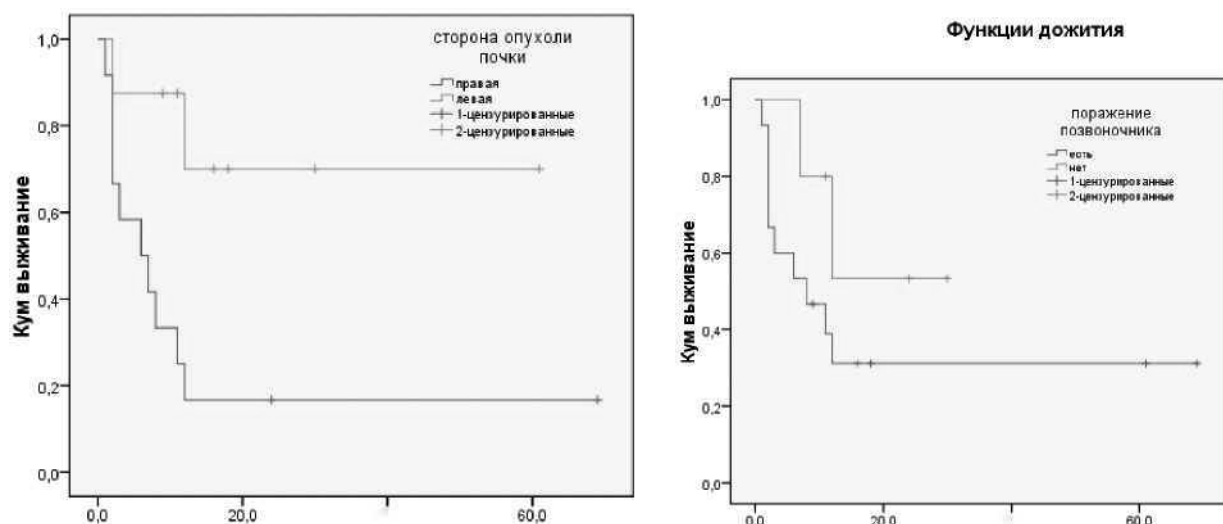


Рисунок 6 - выживаемость в зависимости от наличия поражения позвоночника

[19]. По мнению J. B. DeKernion(1993) около 50% больных на момент установления диагноза уже имеют метастазы, либо они разовьются после радикальной нефрэктомии. Реже встречаются рецидивы через 10 и более лет. По данным Гранова А.М. и со- авт., около 20% пациентов к моменту диагностирования рака, имеют отдаленные метастазы и 25% - мест-но-распространенные формы. Примерно 50% больных требуют системного лечения из-за диссеминации опухолевого процесса. На момент первичной диагностики метастазы в легкие выявляются в 75%, метастазы в лимфоузлы и мягкие ткани - в 36%, метастазы в кости в 20%, метастазы в печень - в 18% [20]. При местной распространенности опухоли, 5-летняя выживаемость после проведенного радикального хирургического лечения, по данным различных авторов, не превышает 10-15% [19]. По данным Карякина О.Б. и соавт., прогноз при метастатических формах ПКР еще более неблагоприятен: средняя выживаемость не превышает 10 месяцев, 2-летняя - 20%, 5-летняя - 2% [21]. Dea(1999) сообщает о 21 случае хирургического лечения метастазов рака почки в сочетании с лучевой терапией, из них 18 пациентов прожили более 2-х лет. В исследовании Лазарева А.Ф. и соавт., в группе пациентов, страдавших местно-распространенным раком почки и получивших комплексное лечение в объеме нефрэктомии и послеоперационной лучевой и иммунотерапии, рецидив опухоли в первые 2 года наблюдения возник у 1 из 17 пациентов, а в контрольной группе хирургического лечения у 6 из 32 больных [22]. Совершенно противоположные результаты получены PeelingW. с соавт. [23]. Авторы провели исследование результатов лечения у 240 больных. Послеоперационное облучение получили 68 больных. Пятилетняя продолжительность жизни среди облученных была 25%, а среди только оперированных 52%. В группе больных, где опухоль не распространялась за пределы капсулы почки, пятилетняя продолжительность жизни среди оперированных и облученных составила 56%, а только оперированных - 73%. При генерализации опухолевого процесса пятилетняя продолжительность жизни только оперированных была выше (38%), чем у оперированных и облученных (13%). У неоперированных больных, но облученных, результаты хуже, чем у нелеченных. AgnerO.с соавт. (1986) отметили, что трехлетняя продолжительность жизни в группе больных, леченных только оперативным методом - 72%, а в группе больных, леченных комбинированным методом - 54%. Аналогичные результаты получены EberhardtH., Cox C. с соавт [24, 25, 26]. По данным Фигурина и соавт. (2003), 5-летняя выжи-

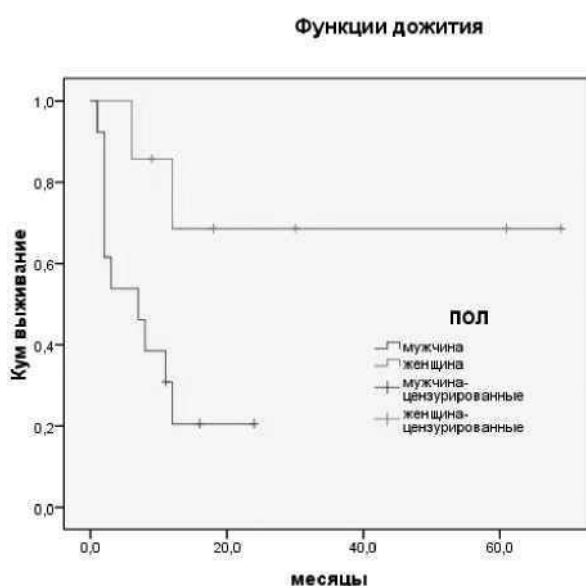


Рисунок 7 - Выживаемость в зависимости от пола пациента

ваемость больных, получавших предоперационную лучевую терапию составила 41,2%, а не получавших -52,2%. AbbatucciJ. с соавт. считают значение радиационной терапии не доказанной [27]. Столь противоречивые суждения о целесообразности лучевой терапии в лечении рака почки и ее метастазов, породили и различные отношения к ее применению. Непосредственное воздействие на опухоль почки и ее метастазы подтверждается не только единичными наблюдениями уменьшения опухоли, но и ангиографическим исследованием. На ангиограммах, сделанных после облучения, более четко выявляется опухолевый узел, уменьшается количество сосудов, спадаются расширенные вены клетчатки. При морфологическом исследовании удаленных опухолей обнаруживается некроз и места обызвествления. Lacy S. с соавт. у трех больных из восьми на ангиограммах отметил эффект, Cox C. Соавт. - у восьми больных из 14 [25]. Приведенные выше данные заставили сомневаться в укоренившемся мнении в резистентности рака почки к лучевому воздействию. Скорее всего, речь идет о неспособности доставить нужную дозу к очагу поражения. Ограничения налагаются вследствие центрального топографического размещения почек и соседства их с кишечником, печенью и спинным мозгом. Высказывается мнение о необходимости подведе-

Таблица 1 - Выживаемость в зависимости от различных факторов

	Пол		Сторона поражения почки		Поражение позвоночника	
	мужчины	женщины	правая	левая	есть	нет
	(n=13)	(n=7)	(n=12)	(n=8)	(n=15)	(n=5)
Общая выживаемость	23,1%.	71,4%.	16,7%.	75,0%.	33,3%.	0%

ния к опухоли и области регионарного метастазирования доз радиации, близких к канцерцидным. Высокие дозы лучевой терапии с паллиативной целью при болезненных костных метастазах оказались эффективными у 50-75% всех больных с почечно-клеточным раком [28, 29,30] (уровень доказательности 3). Таким образом, на основании приведенных литературных данных, нельзя дать однозначную оценку месту лучевой терапии в лечении рака почки и его метастазов.

Выводы

Следует еще раз отметить, что лечение этих крайне тяжелых больных носит паллиативный характер, задачей которого, прежде всего, является улучшение качества жизни. С использованием лучевой терапии и бисфосфонатов нам удалось достичь этой цели с относительно высокими показателями выживаемости пациентов. Предварительные результаты исследования показали высокую клиническую эффективность предлагаемого режима лечения. Определены факторы, которые приводят к снижению выживаемости, однако вопрос того, что являются ли они факторами риска, остается открытым, изучение которого необходимо в дальнейших исследованиях.

Список литературы

1. Bohnenkamp B., Romberg W., Sonnentag W. Prognosis of metastatic renal cell carcinoma related to the pattern of metastasis [author's transl] // J. Cancer Res. Clin. Oncol.- 1980.-Vol. 96, N 1.-C. 105-14.
2. Friedland J. Local and systemic radiation for palliation of metastatic disease // Urol. Clin. North Am. - 1999.-Vol 26, N 2.-C.391-402.
3. Mc Quay H.J., Collins S.I., Carrol D. Radiotherapy for the palliation of painful bone metastases // Cochrane Database Sys. Rev.- 2000.-N 2.-CD001793
4. Wu J.C., Wong R., Johnston M. et al. Cancer Care Ontario Practice Guidelines Initiative Supportive Care Group, Meta- analysis of dose fractionation radiotherapy trials for the palliation of painful bone metastases // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. - 2003.-Vol.55, N3.-C.594-605.
5. The Bone Trial Working Party 8 Gy single fraction radiotherapy for the treatment of metastatic skeletal pain: randomised comparison with a multifraction schedule over 12 months of patient follow-up // The Bone Trial Working Party Radiother Oncol.- 1999.-Vol.52, N2.-C.111-121.
6. George R., Jeba I., Ramkumar R. et al. Interventions for the treatment of metastatic extradural spinal cord compression in adults // Cochrane Database Syst. Rev.-2008.-Vol.8, N 4.-CD006716.
7. Rades D., Lange M., Veninga T. et al. Preliminary results of spinal cord compression recurrence evaluation (score-1) study comparing short-course versus long course radiotherapy for local control of malignant epidural spinal cord compression // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.- 2009.-Vol.73, N1.-C.228-234.
8. Chow E., Wong R., Hruby G. et al. Prospective patient- based assessment of effectiveness of palliative radiotherapy for bone metastases // Radiother. Oncol.- 2001.-Vol.61.- N1.-C.77-82.
9. Mercadante S. Malignant bone pain: pathophysiology and treatment // Pain.- 1997.-Vol.69, N1-2.-C.1-18.

10. Price P., Hoscin P.J., Easton E. et al. Prospective randomised trial of single and multifraction radiotherapy schedules in the treatment of painful bone metastases
11. Sze W.M., Shelley M., Held I. et al. Palliation of metastatic bone pain: single fraction versus multifraction radiotherapy a systematic review of randomised trials // Clin. Oncol.- 2003.-Vol.15, N6.-C.345-52.
12. Kankuri M., Pelliniemi T., Pyrhonen S. et al. Feasibility of prolonged use of interferon- alpha in metastatic kidney carcinoma: a phase II study // Cancer.- 2001.-Vol.92, N 4.-C. 761-7.
13. Eoleman R.E. Potential use of bisphosphonates in the prevention of metastasis in early-stage breast cancer // Clin. Breast. Cancer.-2007.- Vol.7; Suppl. 1.s29-s35.
14. Zometa N.J. (zoledronic acid) // Injection product label.-2004. - Novartis Pharm Corp., NJ.
15. Saad H., Higano C., Sartor J. et al. The role of bisphosphonates in the treatment of prostate cancer; recommendations from an expert panel // Clin. Genitourin Cancer. - 2006.-Vol.4, N 4.-C.257-62.
16. Hendenreich A., Hofmann R., Engelmann U. The use of bisphosphonates for the palliative treatment of painful bone metastasis // J. Urol.- 2001.-N1
17. Weinfurt K., Anstrom K., Castell C. et al. Effect of zoledronic acid on pain associated with bonemastasis // Ann. Oncol.- 2006.-Vol.17, N 6.-C.986-9.
18. Kaplan H.S., Meior P. Nouparemetrir estimation fram incomplete observations // J. Amer. Stat. Assos.- 1958.- Vol. 53.-P.457- 481.
19. Маевручев А.С., Суконко О.Г., Красный С.А. // Мат.научно-практ.конф. онкологов республики Беларусь, 6-я: тезисы докладов.- Минск, 1994.- С.143.
20. Дарьялова М. и соавт. Наш взгляд на комбинированное лечение злокачественных опухолей // Российский онко-логический журнал.-1998.-№ 3.- С. 28-31.
21. Карякин О.Б., Хнычев С.С., Сафиуллин К.Н., Дмитренко Ю.О. // Мат. 3-й Всероссийской науч. конф. - М., 1999.- С. 191-193.
22. Лазарев А.Ф. и соавт. Лечение местно-распространенного рака почки // Российский онкологический журнал.- 2003.- №1.- С. 7-10.
23. Peeling W.etal. Post- Operative Irradiation in the Treatment of Renal-cell Carcinoma // Brith. J. of Urology.- 1969.-Vol. VXL, № 1.- P. 23-31.
24. Фигурин К.М., Подрезульский К.Э. Рак почки // Рус-ский медицинский журнал. - 1998.- Т. 6, № 10.
25. Cox C.etal. Renal carcinoma. 28 year review with emplasis on rationale and feasibility of preoperative radiotherapy // J. Urol.- 1970.-Vol. 104.- P. 51.
26. Eberhardt C., Strietzel M., Raatzsch H.. Zur Strahlen the rapie maligner Nieren tumoren // Radiobiol.- 1969.- Vol. 10, № 6.- P. 719-728.
27. O. Abbataciuti et al. Apropos de 128 tumeurs de l'adulte traitées a l'institute Gustave-Roussy et au Centre Francois- Bacles // J. radiol.,electrol. et med. nucl. - 1974. - Vol.55, №11.- P. 791-795.
28. Halperin E.C., Harisiadis I. The role of radiation therapy in the management of metastatic renal cellular carcinoma // Cancer.- 1983.-Vol.51, № 4.-C.614-7.
29. Onufrey V., Mohiuddin M. Radiation therapy in the treatment of metastatic renal cell carcinoma // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.- 1985.- Vol.11, №11.-C.2007-9.
30. Formal J.D. The role of radiation therapy in the management of carcinoma of the kidney // Sem.Urol.- 1989.- Vol.7, № 3.-C.195-8.

Тұжырым

И.Ишкенин, В.Б.Ким, М.А.Ибраймова

Қазақтың онкология және радмология ҒЗИ

Үйрек рагы кезіндегі сүйек қаңқасының метастаздық бұзылысымен науқастарға паллиативті көмекке арналған бисфосфонат және сәулелі терапияны қолдану.

бүйрек - жасушасындағы катерлі і^а агрессивті және ез агеынада жылдам дамидын катерлі іт^ажатады, кебіесе қаңқа сүйекке кеітмент асқынын оны зақымдайды.

Зақымдалған орындарта сәуле беру арқылы қатты ауыртанды азайтута және !активті түйінінің есуі уақытта тоқтатута болады. Бисфосфонатты ингибиция және сәулелі терапияны қосып емдеу ұзақ

уақытта сүйекке шед! Сәулелі терапияның ттелері эсерше бата бершд^ сәуленің жиық реакциялары, емделген наукастардың емір суру сапасы, емделген наукастардың жекеленген қорытындылары. Сәулелі терапияны бисфосфонаттар- мен бірге қолдану арқылы ете ауыр наукастардың емір суру сапасын жақсарттық.

Түйінді сөздер: бүйрек рагы, метастаз, сәулелі терапия, Бисфосфонат.

Summary

E.I.Ishkinin, V.B..Kim, M.A.Ibraimova .

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Radiation therapy and bisphosphonates for the palliative care of patients with metastatic lesions of bones kidney cancer.

Renal cell carcinoma is an aggressive and unpredictable malignant tumors is often complicated by bone metastases. The irradiation of lesions can be achieved by temporal stop of growth of the tumor and reduction of pain. Radiation therapy in combination with bisphosphonates inhibits a bone resorption for a long time. The estimation the immediate effectiveness of radiation therapy, the frequency of radiation reactions, evaluation of quality of life, long-term results in treated patients. Using the radiation therapy and bisphosphonates, we achieved a goal to improving the quality of life of such extremely heavy patients.

Keywords: kidney cancer, metastasis, radiotherapy, bisphosphonate.

УДК: 616.661-006-08

Бегимбетова Р.С.

Жамбылский областной онкологический диспансер, г. Тараз

Лучевая терапия рака шейки матки

Аннотация. Более чем у 90% больных раком шейки матки используется лучевая терапия) в качестве самостоятельного или как компонент комбинированного лечения.

Цель исследования дать оценку эффективности сочетанной лучевой терапии при раке шейки матки. За период с 2009 по 2011 гг. сочетанную лучевую терапию получили 58 женщин, больных раком шейки матки. Диагноз верифицирован у всех больных, III-IVB стадия заболевания.

Суммарные очаговые дозы в зависимости от стадии заболевания составили: в точке А - 70-76 Гр в точке В - 50-56 Гр. Фракционирование в разовой дозе 10 Гр 1 раз в неделю с количеством фракций 5 проводилось больным со II-III стадией заболевания при отсутствии патологии со стороны смежных органов и аденогенной структуры опухоли. Повышение эффективности и результаты сочетанной лучевой терапии при раке шейки матки зависят: от индивидуального подхода к лечению больных; от объема и распространенности опухолевого процесса; от рационального планирования лучевой терапии.

Ключевые слова: рак шейки матки, лучевая терапия

Лучевая терапия используется более чем у 90% больных раком шейки матки (РШМ) в качестве самостоятельного или как компонент комбинированного лечения. В определении тактики лечения РШМ решающее значение имеет стадия распространенности локализации процесса и морфологическое строение опухоли. Если сочетанная лучевая терапия при ранних стадиях I-IIA является методом выбора наряду с комбинированным лечением, то для больных с местнораспространенными формами заболевания (стадии IIB, IIIA, IIIB, IVA) сочетание лучевой терапии, основной, чаще всего единственный, метод лечения.

Цель

- оценка эффективности сочетанной лучевой терапии при раке шейки матки.

Материалы и методы

В Жамбылском областном онкологическом диспансере внутрисполостная лучевая терапия проводится на аппарате «Multisource» с источником Co-60, который эксплуатируется с 2009 года. Данный аппарат имеет ряд преимуществ перед предыдущим аппаратом «АГАТ-В»:

- обеспечение дифференциального подхода и выбора способа внутрисполостного облучения;
- сокращение длительности сеанса облучения до нескольких минут;
- формирование индивидуальных дозовых распределений любой формы и протяженности;
- индивидуальные подходы к режимам фракциониро-

ванного облучения;

- индивидуальное дозиметрическое планирование;
- определение доз во время лечения не только в т. А и т. В, но и в точках мочевого пузыря и прямой кишки.

За период с 2009 по 2011 гг. сочетанную лучевую терапию получили 58 женщин, больных раком шейки матки. Диагноз верифицирован у всех больных, III-IVB стадия заболевания.

Все больные РШМ были распределены по стадиям следующим образом: IA - 9 больных, IIA-IVB была у 42 пациентов, IIIA- IVB имели 7 женщин. Больные с IIB степенью прошли дистанционную гамма-терапию после расширенной экстирпации матки с придатками и без придатков. За 2 года, прошедших после облучения, признаков рецидива заболевания не наблюдалось. Больные со IIIA стадией заболевания прошли по 2-3 курса неoadъювантной терапии, затем расширенную операцию и послеоперационную лучевую терапию. Данных за рецидив нет.

Проведение неoadъювантной химиолучевой терапии 8 больным со IIIA стадией заболевания не позволило достичь регрессии опухолевого процесса и поэтому оперативное лечение не было произведено. Сочетанная лучевая терапия привела к стойкой ремиссии у 3 больных, а остальные 5 больных продолжили получать специлечение.

Сочетанная лучевая терапия проводилась 18 больным со IIB стадией заболевания с конкурентной химиотерапией с последующей химиотерапией. Оперативного лечения никому не проводилось. Стойкая ремиссия достигнута у 5 больных, остальные продолжали получать специлечение.

Больным с III стадией заболевания проводили самостоятельную лучевую терапию, пять из которых получили на первом этапе химиотерапию. У трех больных, на фоне проведенного лечения, продолжается прогрессирование процесса. У четырех больных достигнута стабилизация процесса.

Современные принципы лучевой терапии предусматривают необходимость сочетанного воздействия внутрисполостного и дистанционного компонента. На I этапе проводилась дистанционная лучевая терапия на аппарате «THERANRON» с источником Co-60 с облучением первичного очага и зон регионарного метастазирования до СОД 16-20 Гр до контактной терапии. На II этапе латеральных отделов параметральной клетчатки и лимфатических узлов - до суммарно-очаговой дозы 16-20 Гр, до контактной терапии. На II этапе латеральных отделов параметральной клетчатки и лимфатических узлов до СОД 40-44 Гр с присоединением внутрисполостного компонента с использованием следующих режимов фракционирования:

- фракционирование в разовой дозе 5 Гр два раза в неделю, число фракций - 10;
- фракционирование в разовой дозе 10 Гр 1 раз в неделю, число фракций - 4-5.

Суммарные очаговые дозы в зависимости от стадии заболевания составили: в точке А - 70-76 Гр, в точке В - 50-56 Гр. Фракционирование в разовой дозе 10 Гр 1 раз в неделю с количеством фракций 5 проводилось больным со II-III стадией заболевания при отсутствии патологии

со стороны смежных органов и адено-генной структуры опухоли.

Вывод

Повышение эффективности и результаты сочетанной лучевой терапии при раке шейки матки зависят:

- от индивидуального подхода к лечению больных;
- от объема и распространенности опухолевого процесса;
- от рационального планирования лучевой терапии.

Список литературы

1. Лучевая терапия в лечении рака. Практическое руководство ВОЗ. - М.: Медицина, 2000.-338 с.
2. Ставицкий Р.В., Паньшин Г.А., Титова В.А. и др. Характер радиационных повреждений организма при лучевой терапии рака шейки матки //Вопросы онкологии.-2009.- №2.-С.201-205.
3. Подготовка больных к лучевой терапии. /Методические рекомендации КазНИИОуР. - Алматы, 2004.

Тұжырым

Р.С.Бегимбетова

Жамбыл облысының онкологиялық диспансері, Тараз қ.

Жатыр мойны қатерлі ісігінің терапиясы

Жатыр мойны қатерлі ісігі бар науқастардың 90%-да сәуле терапиясы дербес немесе қосарланған компонент ретінде қолданылады.

Зерттеудің мақсаты жатыр мойны қатерлі ісігі кезіндегі біріктірілген сәулелік терапияның эффективтілігін бағалау. 2009 – 2011 жж. аралығында 58 жатыр мойны қатерлі ісігі бар 58 әйел адам сәулелік ем алды. III-IIIВ сатысындағы барлық науқаста диагноз анықталынған. Ауру сатысына байланысты қосынды ошақты доза: А нүктесінен – 70-76 Гр, В нүктесіне 50-56 Гр құрды.

Аурудың II-III сатысындағы науқастарға фракциондау бір реттік дозасы 10 Гр, аптасына 1 рет, фракция саны – 5 жүргізілді, бұл әдісті жүргізу аралық мүшелердің және ісіктің аденогенді құрылымының патологиясының болмауына байланысты. Жатыр мойнының қатерлі ісігі кезіндегі жоғары эффективтілігі және біріктірілген сәулелік емнің нәтижелері – науқастарды емдеудегі жеке бағыттық емге, ісіктің процесстің көлеміне және таралуына байланысты, сәулелік терапияның тиімді жоспарына байланысты.

Түйінді сөздер: жатыр мойнының қатерлі ісігі, сәулелік терапия.

Summary

Beghimbetova R.S.

Zhambyl Regional Oncology Center, Taraz

CERVICAL CANCER THERAPY

More than 90% of patients with cervical cancer using radiation therapy as an independent or as a component of combination therapy.

The aim of the study to assess the effectiveness of combined radiotherapy in cervical cancer. During the period from 2009 to 2011. combined radiotherapy received 58 women with cervical cancer. The diagnosis was verified in all patients, III-IIIВ stage disease.

Summary focal dose depending on the stage of the disease was as follows: point A - 70-76 Gy at point B - 50-56 Gy. Fractionation of a single dose of 10 Gy 1 time per week with the number of fractions was performed 5 patients with stage II-III disease in the absence of pathology of the adjacent organs and structures adenogene tumor. Improving the efficiency and results of combined radiotherapy for cervical cancer depends on: the individual approach to the treatment of patients; from the scope and extent of tumor; rational planning of radiation therapy.

Keywords: cervical cancer, radiotherapy.

Академик Саим Балмуханович Балмуханов - известный ученый, клиницист и общественный деятель

Жизнь и деятельность С. Балмуханова - яркий пример служения своему делу, своему народу. Неистощимое трудолюбие, целеустремленность, настойчивость в овладении знаниями позволили выходцу из простой, сельской семьи ремесленников вырасти от рядового врача до высококвалифицированного клинициста (диагноста и лечебника), доктора медицины. От аспиранта - до всемирно известного ученого, действительного члена Национальной Академии наук Казахстана.

Он - участник Великой Отечественной войны, и его боевые заслуги оценены четырьмя орденами и многими медалями.

Мирная трудовая деятельность С. Балмуханова началась в 1946 г. в Институте хирургии АН КазССР, где он до 1953 года - аспирант (целевая аспирантура в Институте рентгенологии и радиологии МЗ СССР, г. Москва), затем - научный сотрудник. В 1953 г. возглавил кафедру рентгенологии и радиологии Алма-Атинского медицинского института. В 1959 г. защитил докторскую диссертацию в Институте Биофизики АМН СССР (г. Москва).

В 1962 г. С.Б. Балмуханов избран членом-корреспондентом, а в 1967 г. - действительным членом Академии Наук Республики Казахстан.

В 1960-1962 гг. - заместитель директора Института краевой патологии.

С 1962 г. его деятельность связана с Казахским НИИ онкологии и радиологии. Будучи директором, заместителем директора по научной работе, в последние годы - Почетным директором, и в настоящее время - консультантом.

Академик С.Б. Балмуханов является основателем рентгенорадиологической науки и радиобиологии в Казахстане, внес неосценимый вклад в становление и развитие онкослужбы в республике.

Научная деятельность С.Б. Балмуханова многогранна. В начале он изучал вопрос патогенеза лучевых поражений, проверял исследования состояния нервной и сосудистой систем, надпочечников, витаминного баланса при лучевой терапии. Эти работы внесли существенный вклад в представление о радиобиологических процессах в организме.

С.Б. Балмуханов в 1955-56 гг., являясь главным радиологом Минздрава республики, организует экспедиционное изучение заболеваемости сельского населения в зоне Семипалатинского ядерного полигона. В 1957-59 гг., по инициативе К.И. Сатпаева, к изучению этого региона подключается Академия наук республики, и С.Б. Балмуханов, совместно с директором института краевой патологии профессором Б.А. Атчабаровым, принимают участие в научных экспедициях в зоне полигона. Они, вопреки утверждению специалистов военно-промыш-



ленного комплекса о незначительных последствиях ядерных испытаний, выявили 3-4-х кратное увеличение заболеваемости населения вокруг полигона, констатировали лучевые повреждения кожи конечностей и волосистой части головы, слизистых. Изучение и критическая оценка отдаленных последствий ядерных испытаний остаются предметом заботы академика и по сей день.

В 1963 г. С.Б. Балмуханов проходит стажировку за рубежом в США, в крупных онкологических центрах и клиниках Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Чикаго, где он основательно проработал, изучил и освоил новые в те годы технологии лучевой

терапии раковых опухолей с применением бетатронов и линейных ускорителей. Плодотворным результатом овладения новейшей методикой лечения злокачественных новообразований явился первый в СССР капитальный труд «Мегавольтовая лучевая терапия», ставший на долгие годы учебной настольной книгой для рентгено-радиологов.

Основная научная деятельность С.Б. Балмуханова связана с Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии, где он все годы - научный руководитель, определяющий направления развития экспериментальной и клинической онкологии. Под его руководством создана первая в Казахстане клиническая база для лучевого лечения онкологических больных. Не удовлетворяясь возможностями рентгенотерапевтических установок, его усилиями были приобретены и, начиная с 1964-1965 гг., впервые в СССР для проведения лучевой терапии стал применяться технический линейный ускоритель, приспособленный для медицинских целей, и бетатрон с энергией 15 Мэв. Впервые в СССР активны начали проводить лечение быстрыми электронами. Он возглавил комплекс исследований, направленных на улучшение результатов лучевой терапии рака пищевода (являющегося краевой патологией для Казахстана), рака легких, остеогенных сарком, опухолей органов малого таза и др.

Параллельно с клиническими исследованиями, академик С.Б. Балмуханов уделяет пристальное внимание фундаментальным исследованиям - радиобиологии опухолей. Он стоял у истоков широкомасштабных радиобиологических исследований в Казахстане. По результатам исследования радиочувствительности злокачественных новообразований, Казахский НИИ онкологии и радиологии вышел на мировой уровень. Новизна исследований была предметом обсуждения на Всесоюзных симпозиумах с участием крупнейших специалистов мира (М. Tubiana, О. Scott, Л. Revesz, С.П. Ярмоненко и др.), доложены на многих международных форумах и опубликованы в пре-

стижных журналах, таких как Nature, Cancer и др.

В 1997 г. известный радиобиолог, лауреат Государственной премии СССР С.П. Ярмоненко издал в Москве книгу «Отечественная радиобиология. История и люди», где пишет: «Отечественная клиническая радиобиология располагает значительными достижениями, в настоящее время она представлена в четырех крупных центрах. Одним из этих центров, в котором достаточно широко проводятся клиничко-радиобиологические исследования, является НИИ онкологии и радиологии МЗ Казахстана, где они начаты с середины 60-х годов по инициативе и под руководством С.Б. Балмуханова. Наиболее значимые результаты здесь получены в области изучения зависимости эффективности лечения от ростовых параметров опухолей, а также в области оптимизации использования радиомодифицирующих агентов, в частности, электронакцепторных сенсibilизаторов».

Саим Балуанович, с присущим ему чувством нового в науке, неутомимостью в поисках, способностью увлечь за собой других, сплотил вокруг себя в КазНИИОиР и в Академии наук активные научные коллективы. Им была создана научная школа, которая занимается теоретической разработкой методов лучевой терапии, изучением биологии опухолей, исследованием первичной и приобретенной радиорезистентности новообразований, поисками путей радиосенсибилизации опухолевых и защиты нормальных тканей от радиации. В научных исследованиях в этом направлении проводится широкое контактирование с зарубежными исследовательскими центрами (Швеция, Англия, Германия, Япония), что вывело нашу республиканскую науку на мировой уровень.

И по сей день проблемы фракционирования и пространственного распределения дозы при облучении, использования особенностей роста опухолей для оптимизации режимов лучевой терапии, пути управления радиочувствительностью новообразований и нормальных тканей являются актуальными. В последние годы международный резонанс получили разработанные академиком, совместно с учениками, новые методы лучевой терапии с использованием радиомодификаторов, благодаря которым удалось повысить эффективность лечения ряда опухолей на 20-35% и спасти жизни сотням больных.

Исследования академика С.Б. Балмуханова нашли отражение в 450 научных работах, в том числе в 6 монографиях, более 50 публикациях в дальнем зарубежье. Он неоднократно представлял советскую науку на международных конгрессах (США, Япония, Швеция, Англия,

Франция и др.), был организатором ряда всесоюзных симпозиумов с международным участием.

К тематике СИЯП С.Б. Балмуханов смог вернуться только после распада СССР. Итоги многолетних исследований легли в основу его книг: «Ядерный полигон моими глазами» (1998) и «Theradiationsituationandpopulationhealth in Semipalatinsk province» (Вашингтон, 1999). Он твердо знает, что пострадавшим на полигоне нужны не исследования, а конкретная помощь, прежде всего медицинская. Такую помощь, например, семипалатинцы получили от Международного Фонда Помощи, в чем личная заслуга его и Президента фонда профессора Карла Коха. Так, близ полигона в п. Кайнар по инициативе С.Б. Балмуханова в 1999 г. был открыт Региональный реабилитационный центр, куда доктор Кох направил необходимое современное оборудование, специализированную мебель, новые приборы и медикаменты. «Подобная адресная помощь - это то, в чем нуждается пострадавший регион», - с такими словами С.Б. Балмуханов выступил в Токио 6 сентября 1999 года на Международной Конференции ООН по проблемам Семипалатинского Полигона, где было рассмотрено 38 проектов на общую сумму 48 млн. долларов США для оказания действенной помощи региону СИЯП.

За вклад, внесенный в дело оказания помощи пострадавшим от испытаний ядерного оружия, а также в дело борьбы за безъядерный мир, академик С.Б. Балмуханов был удостоен Международной Премии Мира им. Нагаи Такачи (Япония) и почетного звания Лауреата. Помимо научной и педагогической деятельности академик С.Б. Балмуханов ведет большую общественную и научно-организационную работу. Он член многих республиканских и международных научных комиссий, советов, комитетов, редакций энциклопедий и журналов. Неуемную активность и неиссякаемую энергию он проявил в деле защиты мира и здоровья людей, будучи почти 20 лет президентом Казахстанской Ассоциации Всемирного движения «Врачи за предотвращение ядерной войны», удостоенного в 1985 г. Нобелевской премии мира, а также по линии Международного движения «Невада-Семипалатинск».

Отечество высоко оценило его боевые и трудовые заслуги, наградив двумя орденами Ленина, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, многими медалями СССР, двумя Почетными грамотами Верховного Совета Республики Казахстан, присвоив почетное звание «Заслуженный деятель науки».

Статья подготовлена профессором Сейтказиной Г.Д.

О научно-педагогической, практической и общественной деятельности профессора О.К. Кабиева

В мае 2012 г. исполнилось 80 лет со дня рождения Одака Кабиевича Кабиева. Он остался в памяти его близких, коллег и учеников, прежде всего, как человек большой энергии с научными замыслами в решении проблемы века - борьбы со злокачественными новообразованиями фармакотерапевтическими способами.

В архиве НИИ онкологии и радиологии МЗ РК О.К. Кабиев в своей автобиографии указывает, что родился 20 мая 1932 г. в селе Кус-Куль Каратюбинского района Западно-Казахстанской области в семье служащего.

Отец - Маулебергенов Каби до Великой Октябрьской революции был крестьянином-бедняком, после революции окончил курсы учителей и с 1920 г. работал учителем в начальных школах Западно-Казахстанской области. Мать, Маулебергенова Майхан - домохозяйка.

В 1938 г. О.К. Кабиев начал учебу в Коминтерн-ской средней школе, в 1948 г. окончил среднюю школу в Джамбейтинском районе Западно-Казахстанской области.

В 1948 г. поступил на лечебный факультет Казахского государственного медицинского института в г. Алма-Ате и в 1954 г. окончил его с отличием. Будучи талантливым студентом, занимаясь в научном кружке, проявил интерес к исследовательской работе. С 1954 г. по 1957 г. учился в аспирантуре КазГМИ по специальности «Фармакология». С октября 1957 г. по июнь 1961 г. работал ассистентом кафедры фармакологии КазГМИ. Под руководством профессора Сиверцева И.И. подготовил, и в 1958 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук «К фармакодинамике производных камфоры - оксима, семикарбазона и тиосемикарбазона». Работая в КазГМИ, Кабиев О. активно участвовал в общественной жизни института: вместе со студентами участвовал в уборке урожая, был секретарем комсомольской организации аспирантов и ординаторов, старшим агитатором, внештатным лектором Алма-Атинского обкома Компартии Казахстана.

С ним связана эпоха становления отечественной экспериментальной онкологии, его научное наследие - это не только научное достижение, но и явление общей культуры. По сути, О.К. Кабиев как человек и ученый, как провидец и стратег науки - личность вне времени. В 1961 г. по приказу МЗ Каз. ССР переведен во вновь созданный Научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, где стал организатором лаборатории экспериментальной терапии опухолей, которой бессменно руководил до 1987 г.

Основным направлением работы лаборатории являлся поиск и изучение в эксперименте новых противоопухолевых препаратов растительного и синтетического происхождения (полифенолов, флавоноидов, антрахинонов, производных ацетиленовых спиртов, эфиров, аминов,



ацетилформамидок-сима, трикарбоновых кислот и др.). Проводились исследования по фармакокинетике и фармакодинамике препаратов, механизму действия, изучались закономерности «структура - токсичность», «структура - эффективность» в ряду химических соединений. Изучались вопросы возникновения устойчивости опухоли к химиотерапевтическим препаратам (применяемым в клинике и новым соединениям) и пути устранения лекарственной резистентности. Проводилась работа по комбинированному воздействию химиопрепаратов и облучения на опухоли животных и поиск радиомодифицирующих средств. Исследовалась соматическая

гибридизация опухолевых и нормальных клеток, резистентных к химиопрепаратам, изучались методы культивирования опухолей человека различной локализации для определения чувствительности к химиопрепаратам.

В 1968 г. О.К. Кабиев защитил докторскую диссертацию «Флавоноиды и хиноиды - новые группы антибластомных и радиомодифицирующих соединений (Экспериментальное исследование)», в 1970 г. ему присвоено звание профессора.

В 1973-1980 гг. - работал заместителем директора по научной работе Казахского НИИ онкологии и радиологии, в 1982-1987 гг. - директором КазНИИОиР.

О.К. Кабиев был генератором новых идей, чувствуя перспективные направления в современной науке. В 1975 году, я, как один из его учеников, поступил в аспирантуру Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии в лабораторию экспериментальной химиотерапии опухолей. Под руководством О.К. Кабиева проводились научные эксперименты на лабораторных животных с целью изучения перекрестной резистентности и коллатеральной чувствительности опухолей, поиска путей предупреждения и преодоления лекарственной резистентности новообразований с использованием новых отечественных растительных соединений. Результаты проведенных экспериментальных работ были обобщены в кандидатской диссертации: «Изучение перекрестной устойчивости и коллатеральной чувствительности опухолей к различным группам противоопухолевых веществ и поиск путей предупреждения и преодоления лекарственной устойчивости новообразований», которую я успешно защитил в 1978 г.

О.К. Кабиев был человеком неисчерпаемой энергии, его незаурядный дар ученого и организатора совмещался с глубокой принципиальностью, сердечной теплотой, доброжелательностью. Являясь моим научным руководителем, он сумел разглядеть в молодом исследователе талант ученого, что повлияло на продолжение моих научных исследований в области онкофитофармакологии во вновь организованной лаборатории предклинической фармакологии. Научные исследования проводились в

лаборатории совместно с доктором биологических наук, заведующим лабораторией С.М. Верменичевым, который также был учеником О.К. Кабиева.

Результаты научной работы О.К. Кабиева были апробированы и признаны в СССР и за рубежом, свидетельством чего явились его неоднократные выступления со своими данными на республиканских, всесоюзных и международных форумах с участием ведущих ученых в области онкологии и фармакологии. Работа лаборатории отличалась высоким профессиональным уровнем специалистов и качеством проводимых исследований. Подтверждением этого явились доклинические испытания десятков различных соединений в рамках Всесоюзной государственной программы по злокачественным новообразованиям.

Исследования профессора О.К. Кабиева и его сотрудников имели не только важное теоретическое значение, но и весомые практические результаты. 7 препаратов прошли на базе лаборатории полные пред-клинические испытания и были предложены для дальнейшего клинического изучения в качестве противоопухолевых средств (лейкоэфдин, глиофен-основание, глиофен-гидрохлорид, изафен, алхидин, альнусидин, арглабин). Я, как его ученик, соратник и последователь идей своего учителя, совместно с академиком НАН РК

С.М. Адекеновым в АО Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» провел многолетнюю работу в поиске новых сесквитерпеновых лактонов для создания на основе их новых отечественных противоопухолевых лекарственных препаратов. В результате скрининга и углубленного изучения специфической активности, острой и хронической токсичности сесквитерпеновых лактонов и их производных был выявлен противоопухолевый препарат «Арглабин», полученный из одноименного сесквитерпенового гамма-лактона, выделенного из эндемического растения - полынь гладкая (*Artemisiaglabella* Kar. et Kir Asteraceae). Мною был проведен комплекс фармакологического и клинического изучения противоопухолевого препарата «Арглабин». 3 декабря 2007 г. Глава государства Н.А. Назарбаев присудил мне, совместно с группой ученых, возглавляемых академиком НАН РК С.М. Адекеновым, высокую награду - Государственную премию Республики Казахстан в области науки и техники за представленную научную работу «Развитие в Казахстане исследований по химии природных сесквитерпеновых лактонов, поиску и созданию на их основе новых лекарственных веществ, организация промышленного производства оригинальных отечественных фитопрепаратов».

О.К. Кабиев оставил большое творческое наследие, он является автором свыше 200 научных публикаций, монографии «Природные фенолы - перспективный класс противоопухолевых и радиопотенцирующих соединений», более 20 изобретений, относящихся к различным разделам теоретической и экспериментальной онкологии. Им присущи оригинальность и глубина выдвинутых идей, масштабность, смелая практическая направленность, тесная связь результатов фундаментальных исследований с потребностями клинической онкологии.

Подготовил 12 кандидатов наук, 3 докторов наук.

О.К. Кабиев активно занимался и общественной работой в системе Министерства здравоохранения республики. Он с 1971 по 1977 г. работал заместителем Председателя Ученого медицинского совета МЗ на общественных началах и много времени уделял вопросам планирования и координирования медицинской науки республики. Был председателем регионального бюро Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, заместителем председателя правления Казахского республиканского общества фармакологов, председателем республиканского общества онкологов.

Широта взглядов творческой личности со всеми ее индивидуальными особенностями была присуща О.К. Кабиеву. Его отличала, характерная для отечественной интеллигенции, высокая внутренняя культура, а глубокий аналитический ум и преданность научному долгу позволили О.К. Кабиеву стать одним из корифеев и творцом отечественной медицины и экспериментальной онкологии.

За многолетний добросовестный труд и успешную научную работу награжден Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР, нагрудным знаком «Изобретатель СССР», значком «Отличнику здравоохранения», медалями «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, «Ветеран труда».

Светлой памяти моего учителя профессора О.К. Кабиева я посвятил свой многолетний научный труд «Фармакологическое изучение природных соединений Казахстана». Память о талантливом человеке и руководителе и сегодня освещает научный путь в области экспериментальной, клинической онкологии и фитофармакологии.

С уважением, д.м.н., профессор, академик НАЕН РК, лауреат Государственной премии в области науки и техники, Заслуженный деятель в области науки РК, зав. кафедрой клинической фармакологии с курсом доказательной медицины, главный внештатный фармаколог МЗ РК Рахимов К.Д.

Газиз Сергазинович Канафьянов

10 октября 1944 года родился доктор медицинских наук профессор Газиз Сергазинович Канафьянов - известный ученый, высокообразованный гражданин, интеллигент от природы, гордость казахской нации и сын своего народа.

Вся жизнь Газиза Сергазиновича была связана с медициной и медицинской наукой. Окончив в 1969 году Семипалатинский медицинский институт, он стал работать в качестве ассистента на кафедре нормальной физиологии этого же института.

Далее молодого специалиста направили в целевую аспирантуру КазНИИ онкологии и радиологии в г. Алматы. Курс аспирантуры он проходил под научным руководством известного ученого академика С.Б. Балмуханова. В дальнейшем вся его деятельность связана с нашим институтом, где Газиз Сергазинович прошел путь от аспиранта до заместителя директора по науке. Последние 15 лет жизни он проработал на этом посту. Хотелось бы отметить, что защита кандидатской диссертации состоялась в 1977 году в одном из крупнейших научно-исследовательских институтов - НИИ медицинской радиологии в г. Обнинске.

Становлению Г.С. Канафьянова как ученого-радиолога, организатора медицинской науки способствовала его постоянная практическая, научная и преподавательская деятельность. Он одновременно преподавал на кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии Казахского Национального медицинского Университета.

Газиз Сергазинович постоянно учился, повышая квалификацию, в таких крупных авторитетных учреждениях как Институт Усовершенствования врачей г. Москва (дважды), на кафедре онкологии АГИУВ, в научно-исследовательском институте радиационной медицины в г. Дубай (ОАЭ). Одновременно он окончил курс «Управление отраслью здравоохранения в условиях бюджетно-страховой медицины», предвидя новые веяния в развитии здравоохранения.

Вместе с учеными РЖИ онкологии им. Н.Н.Петрова (г. Санкт-Петербург) и института проблем онкологии (г. Киев), Газиз Сергазинович занимался исследованием вопросов диагностики и лечения рака молочной железы.

Его диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук «Функциональное состояние гепатобилиарной системы и эндокринно-иммунологические изменения у больных раком молочной железы» была очень своевременной и необходимой, ибо она была и остается актуальной проблемой онкологии и в сегодняшние дни.

Основным направлением научной деятельности в последующие годы является изучение комплекса радионуклидных методов в диагностике и оценке эффективности лечения опухолевого процесса. Одновременно с этим, Газиз Сергазинович изучал влияние малых доз радиации на население в регионе СИЯП (Семипалатинского Испытательного Ядерного Полигона) и вел поиски путей реабилитации. В дальнейшем реабилитационные анти-



оксиданты изучались и применялись как средства в лучевой терапии злокачественных новообразований.

Творческие изыскания Газиза Сергазиновича изложены в более 100 научных трудах, в 2 монографиях и учебном пособии на казахском языке по радионуклидной диагностике. Газиз Сергазинович является научным руководителем диссертационных исследований аспирантов и соискателей.

Как заместитель директора по науке, Г.С. Канафьянов участвовал в планировании научно-исследовательской деятельности института, в координировании научных разработок, выполнении исследований по грантам, укреплял международные связи с профильными учреждениями ряда стран, организовывал помощь научным организациям, осуществлял внедрение в практику здравоохранения научных достижений КазНИИ онкологии и радиологии.

Будучи заместителем председателя Ученого совета и Диссертационного совета, Газиз Сергазинович активно участвовал в подготовке научных кадров и молодых ученых для страны.

Являясь председателем радиологического совета института, работал в контакте со специалистами МАГАТЭ и Комитета по атомной энергетике, что способствовало развитию радиологической службы в Казахстане и его признанию на мировом уровне.

Под руководством Газиза Сергазиновича Канафьянова в институте организовывались актуальные тематические циклы усовершенствования врачей по онкологии, лучевой диагностике и лучевой терапии для специалистов онкологических учреждений Казахстана.

Он являлся одним из основных организаторов республиканских и международных научных и научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров и совещаний.

Результатом организаторской работы Г.С. Канафьянова, связанной с помощью регионам Казахстана, являлось открытие лаборатории радиоизотопной диагностики в г. Атырау, Павлодаре, Семипалатинске и Кокшетау. Он был бессменным куратором онкологической службы Восточного Казахстана, считал это своим долгом, так как был сыном этого края, и к этой работе Газиз Сергазинович относился особенно трепетно, ответственно, с большой любовью.

В 1999 году по инициативе и непосредственном участии Газиза Сергазиновича в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области при районной больнице (с. Акжар) открыто отделение профилактики злокачественных новообразований. Необходимость этой структуры очевидна, т.к. среди жителей Тарбагатай и пограничных районов, в связи с изменением экологической обстановки, участились заболевания раком желудочно-кишечного тракта и других локализаций.

За трудовые заслуги, научную и общественную дея-

тельность Г.С.Канафьянов был награжден почетными грамотами Министерства Здравоохранения Казахской ССР и Республики Казахстан, грамотами областных и городских органов власти, являлся «отличником здравоохранения».

Профессионализм, исключительная работоспособность, организаторский талант, доброжелательность к

людям снискали Г.С. Канафьянову глубокое уважение. Память о нем хранят соратники, ученики, друзья, ученые и весь коллектив института.

Коллектив КазНИИОур